

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO PARA PACIENTES CON DERECHO A PRESTACIÓN SANITARIA PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA

INDICE

1	OBJETO DEL CONTRATO	3
2	PROCEDIMIENTOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	3
2.1	LOTES 1,2,3,4,5 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS	3
2.2	LOTE 6. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ENDOSCOPIAS	4
2.3	LOTE 7. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS DEL SAOS	4
2.4	LOTE 8. SERVICIO DE EMISIÓN DE INFORMES E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ULTRASONIDOS	5
3	MEDIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	5
4	ÁMBITO DE APLICACIÓN	5
5	OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA	6
6	ACCESO A LOS SERVICIOS	6
7	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	7
8	REQUISITOS MÍNIMOS. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. LOTES 1,2,3,4,5. 7	7
8.1	BLOQUE A. NORMATIVA, ESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CARTERA DE SERVICIOS	7
8.2	BLOQUE B. PERSONAL	11
8.3	BLOQUE C. ORGANIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	13
8.4	BLOQUE D. INFORME CLÍNICO DE RESULTADOS	17
8.5	BLOQUE E. REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	19
8.6	OTRAS CONSIDERACIONES	22
9	REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ENDOSCOPIA (COLONOSCOPIA) LOTE 6	23
9.1	BLOQUE A. EQUIPAMIENTO	23
9.2	BLOQUE B. LOCALES E INSTALACIONES	26
9.3	BLOQUE C. RECURSOS HUMANOS	28
9.4	BLOQUE D. ORGANIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	28
9.5	BLOQUE E. REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	30
9.6	BLOQUE F. INFORME DE RESULTADOS	32
10	REQUISITOS MÍNIMOS PARA ESTUDIOS DE SUEÑO (POLISOMNOGRAFÍA) LOTE 7	35
10.1	BLOQUE A. EQUIPAMIENTO	35
10.2	BLOQUE B. LOCALES E INSTALACIONES	36
10.3	BLOQUE C. RECURSOS HUMANOS	37
10.4	BLOQUE D. ORGANIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	38
11	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SERVICIO DE EMISIÓN DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNÓSTICA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ULTRASONIDOS. LOTE 8	45
11.1	INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	45
11.2	REQUISITOS LEGALES	45



11.3 REQUISITOS DE INTEGRACION.....	46
11.4 PROPIEDAD, PROTECCIÓN DE DATOS, SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD.....	49
11.5 OTRAS CONSIDERACIONES.....	51
12 REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICO MEDIANTE ULTRASONIDO.....	52
12.1 BLOQUE A. EQUIPAMIENTO	52
12.2 BLOQUE B. LOCALES E INSTALACIONES.....	54
12.3 BLOQUE C. RECURSOS HUMANOS.....	55
12.4 BLOQUE D. ORGANIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	56
12.5 BLOQUE E. INFORME DE RESULTADOS	59
ANEXO 1	61
ANEXO 2	63
ANEXO 3	64



1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene por objeto la realización de procedimientos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos para pacientes con derecho a prestación de asistencia sanitaria pública en el ámbito de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia.

2. PROCEDIMIENTOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

2.1. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS:

LOTE 1: PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS.CIRUGÍA GENERAL

LOTE 2: PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGÍA

LOTE 3: PROCEDIMIENTOS OTORRINOLARINGOLOGÍA

LOTE 4: PROCEDIMIENTOS UROLOGÍA

LOTE 5: PROCEDIMIENTOS TRAUMATOLOGÍA

	Diagnósticos C.I.E.		Procedimientos C.I.E.		Precio Unitario	Nº	Total
	Código	Descripción	Código	Descripción			
LOTE 1	CIRUGÍA GENERAL						
	574, 575	Colelitiasis y otros trastornos de la vesícula biliar	5122	Colecistectomía	1618,99 €	10	16.189,90 €
			5123	Colecistectomía laparoscópica	1717,88 €	10	17.178,80 €
	550.0	Hernia Inguinal unilateral	53.0	Reparación unilateral h. inguinal	850,00 €	15	12.750,00 €
			54.21	Reparación hernia inguinal unilateral por laparoscopia.	850,00 €	15	12.750,00 €
	553.1	Hernia umbilical	53.41	Hernioplastia (con prótesis)	1025,00 €	10	10.250,00 €
	SUBTOTAL CIRUGIA GENERAL					60	69.118,70 €
LOTE 2	OFTALMOLOGIA						
	366	Cataratas	13.7	Extracción +LIO	730,00 €	150	109.500,00 €
	SUBTOTAL OFTALMOLOGIA					150	109.500,00 €
LOTE 3	OTORRINOLARINGOLOGIA						
	474	Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides	28.2	Amigdalectomía sin Adenoides	378,51 €	10	3.785,10 €
	SUBTOTAL OTORRINOLARINGOLOGIA					10	3.785,10 €
LOTE 4	UROLOGIA						
	600 596.9	Hiperplasia próstata. Trastorno de vejiga no especificado	5122	Resección transuretral	1243,68 €	10	12.436,80 €
	V25.2	Esterilización	63.70	Vasectomía	309,14 €	80	24.731,20 €
	605	Fimosis	64.0	Circuncisión	309,14 €	20	6.182,80 €
	603	Hidrocele	612	Escisión de Hidrocele	583,92 €	30	17.517,60 €
	456.4	Varicocele	63.1	Varicolectomía	729,09 €	15	10.936,35 €
	SUBTOTAL UROLOGIA					155	71.804,75 €



LOTE 5	TRAUMATOLOGIA						
	715.95, 715.95, 716.65, 733.42, 715.25, 714.0	Osteoartrosis de cadera, coxitis, necrosis avascular cadera, coca malum, artritis reumatoide	8151	Sustitución total de cadera con	5.900,00 €	20	118.000,00 €
	715.96, 714.0	Gonartrosis, artritis reumatoide rodilla	8154	Sustitución total de rodilla con prótesis	5.030,00 €	20	100.600,00 €
	735.0, 735.2	Dedo gordo pie valgo	77.54	Escisión de Hallux Valgus	673,00 €	5	20.190,00 €
			77.51	Bunionectomía con corrección de tejido blando y osteotomía del 1er met.		10	
			77.52	Bunionectomía con corrección de tejido blando y artrodesis		10	
			77.53	Otra bunionectomía con corrección de tejido blando		5	
	735.3, 735.4 727.03	Dedo gordo del pie en martillo Dedo en gatillo	77.56	Reparación dedo martillo	776,82 €	5	15.536,40 €
			77.57	Reparación dedo en garra		10	
			77.58	Otra escisión, fusión y reparación dedos pie		5	
	717, 715.36	Trastorno interno de rodilla	80.26	Artroscopia diagnóstica o tera	969,45 €	30	29.083,50 €
	840.6, 726.1, 726.2, 727.61	Rotura tendón supraespinoso, síndrome manguito rotadores de hombro	80.21	Artroscopia de hombro	1.470,00 €	10	29.400,00 €
			81.83	Otra reparación de hombro		10	
	354.0	Síndrome del túnel carpiano	04.43	Liberación del túnel carpiano	605,92 €	55	33.325,60 €
	SUBTOTAL TRAUMATOLOGIA					195	346.135,50 €

2.2. LOTE 6. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ENDOSCOPIAS

LOTE 6	Diagnósticos C.I.E.		Precio Unitario	Nº	Total
	Código	Descripción			
	PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ENDOSCOPIAS				
	11	Esófago - Gastroscopia	106,75 €	200	21350,00 €
	12	Colonoscopia	224,20 €	350	78.470,00 €
	SUBTOTAL LOTE 6			550	99.820,00 €

2.3. LOTE 7. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS DEL SAOS

LOTE 7	Diagnósticos C.I.E.		Precio Unitario	Nº	Total
	Código	Descripción			
	PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DEL SAOS				
	11	Estudio Polisomnográfico Diagnóstico	426,99 €	60	25.619,40 €
	SUBTOTAL LOTE 7			60	25.619,40 €

Código Seguro de Verificación CSV: P24016T0UUVWV05LY5F6IF5HQ9XKIU255IIHQ
 Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P24016T0UUVWV05LY5F6IF5HQ9XKIU255IIHQ>



2.4. LOTE 8. SERVICIO DE EMISION DE INFORMES E IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ULTRASONIDOS

LOTE 8	Diagnósticos C.I.E.		Precio Unitario	Nº	Total
	Código	Descripción			
	SERVICIO DE EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA				
	1	Lecturas de RM Simple	16,00 €	106	1696,00 €
	2	Lecturas de RM Doble	28,00 €	61	1708,00 €
	SUBTOTAL LECTURAS RM			167	3.404,00 €
	1	Lecturas de TC Simple	16,00 €	105	1680,00 €
	2	Lecturas de TC Doble	29,00 €	59	1711,00 €
	SUBTOTAL LECTURAS TC			164	3.391,00 €
	SUBTOTAL EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA			331	6.795,00 €
	PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ULTRASONIDOS.				
	113	Ecografías	37,00 €	750	27.750,00 €
	SUBTOTAL ULTRASONIDOS			750	27.750,00 €
	SUBTOTAL LOTE 8			1081	34.545,00 €

La cantidad fijada para cada procedimiento es estimada, pudiendo ser modificada en función de las necesidades de la administración contratante, con el límite del presupuesto base de licitación. La presentación de oferta a un lote implica la oferta a todos los procedimientos incluidos en ese lote.

Los procedimientos susceptibles de realizarse con Cirugía Mayor Ambulatoria descritos, se facturarán al precio ofertado reducido en un 5%. En el supuesto de que en un mismo paciente se lleven a cabo dos o más procedimientos quirúrgicos en una misma intervención, el procedimiento de menor precio tendrá una reducción de un 25%.

3. MEDIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Las características y los requisitos técnicos que deben cumplir los centros sanitarios serán los que se establecen con carácter de mínimos en este pliego.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La empresa adjudicataria se compromete al tratamiento de los pacientes beneficiarios de la asistencia sanitaria prestada por Sacyl, pertenecientes al ámbito de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia remitidos por el personal facultativo autorizado por Sacyl, en la forma y a través del procedimiento establecido en el presente pliego.



5. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

- 5.1.** El adjudicatario está obligado al cumplimiento del plazo total de vigencia del contrato y a la que su/s Centro/s dispongan, para el cumplimiento de los objetivos asistenciales previstos en el mismo, de los recursos materiales y de equipamiento general, clínico y de quirófanos, en su caso, necesarios para realizar con eficacia, calidad y garantía, las actividades objeto de contrato, así como del personal sanitario y no sanitario que permita la perfecta atención de la actividad contratada.
- 5.2.** Será obligación del adjudicatario mantener actualizada la relación de profesionales que han de realizar los procedimientos quirúrgicos y comunicar a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia de los cambios que se produzcan en relación con los profesionales que prestan la ejecución del contrato.
- 5.3.** Los Centros, Servicios o Establecimientos donde se realice la prestación del servicio público objeto del contrato, dispondrán de Guías de Información al usuario, de hojas de reclamaciones y sugerencias según el modelo establecido por la normativa Autonómica. Con independencia de que el usuario prosiga en su reclamación por los cauces previstos en la normativa, dispondrán de un registro de todas las quejas y reclamaciones que se produzcan.

6. ACCESO A LOS SERVICIOS

A los efectos del presente contrato se beneficiarán los pacientes que se encuentren en lista de espera pendientes de procedimientos que se encuentren dentro de los relacionados en cada bloque objeto de contrato.

- 6.1.** Prestación del Servicio: Los procedimientos quirúrgicos objeto del presente contrato se realizarán en régimen ambulatorio y de hospitalización. Los procedimientos diagnósticos objeto del presente contrato se realizarán en régimen ambulatorio. Esta decisión se ajustará al criterio del facultativo del Complejo Asistencial de Segovia y respetando en todo caso, el régimen de intervención para el que el paciente otorgó su consentimiento. Los pacientes subsidiarios de dichas intervenciones serán avisados por riguroso orden de inclusión en lista de espera.
- 6.2.** Recepción de la solicitud de realización del procedimiento: El Servicio de Admisión del Complejo Asistencial de Segovia enviará las peticiones con el tipo de procedimiento solicitado, junto con la información clínica del paciente, los datos de contacto, a través de correo encriptado, y se recibirán informes por el mismo método de envío, pudiéndose admitir otra vía de comunicación previa autorización de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia.
- 6.3.** Citación: La entidad adjudicataria será la responsable de contactar con los pacientes para informar de las citas, de la preparación quirúrgica y de la intervención si procede. Para considerar a un paciente ilocalizable, será preciso no haber podido contactar con él o con las personas más próximas a



él tras tres llamadas infructuosas (al menos una de ellas habrá tenido lugar por la tarde) y no obtener respuesta en el plazo de tres días hábiles a burofax, telegrama o carta certificada con acuse de recibo. En ese caso, el centro adjudicatario devolverá la solicitud al Complejo Asistencial de Segovia, adjuntando las justificaciones del intento de localización.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las características técnicas y sanitarias que deberán poseer los equipos y los servicios ofertados, así como la dotación de material y personal con que deberán contar, se atenderán a los requisitos generales establecidos por Sacyl, para este tipo de instalaciones.

8. REQUISITOS MINIMOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. LOTES 1_2_3_4_5

8.1. BLOQUE A. NORMATIVA, ESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CARTERA DE SERVICIOS

8.1.1. Normativa

Será de obligado cumplimiento, en todo momento, la normativa legal local, autonómica y estatal vigente, para la construcción, ubicación, puesta en marcha y funcionamiento de este tipo de instalaciones, entre otros, el Real Decreto 1277/2003 de 10 de octubre, que regula las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, el Decreto 49/2005 de 23 de junio, de la Comunidad de Castilla y León, por el que se establece el régimen jurídico y el procedimiento para la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (derogado parcialmente por el Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo) de todos los equipos disponibles, electromédicos o no, y para el material fungible que se precise, debiendo estar todos ellos validados y en correcto estado de funcionamiento.

Será de obligado cumplimiento, en todo momento, toda la reglamentación y normativa legal aplicable vigente tanto a nivel internacional y de la UE, como nacional, autonómica o local, para la ubicación, funcionamiento y seguridad de este tipo de instalaciones (incluyendo criterios internacionales especificados en el real decreto 414/1996 del 1 de Marzo y marca CE) y de todos los equipos utilizados, electromédicos o no, y para todo el material fungible que se precise, debiendo estar todos ellos validados y en correcto estado de funcionamiento.

Se deberá disponer de las correspondientes licencias y/o autorizaciones emitidas por las pertinentes administraciones u organismos.



8.1.2. Accesibilidad

Edificio: Permitirá acceso de vehículos de transporte sanitario

Instalaciones: Permitirán acceso y desplazamiento de pacientes en camilla

8.1.3. Las instalaciones destinadas a la prestación del servicio constarán de las siguientes dependencias y equipamiento:

8.1.3.1. Generales o específicas para el área quirúrgica

- Secretaría y Área administrativa: Existirá el equipamiento necesario para:
 - ✓ Realización y envío de informes de resultados.
 - ✓ Archivo de informes en soporte informático.
 - ✓ Archivo de informes e imágenes en soporte convencional y/o digital.
- Zona de recepción de pacientes y espera de ambulancias
- Sala de espera para pacientes y acompañantes, común o específica para el área de consultas externas y el de procedimientos diagnósticos (en su caso), con aseo y vestuario para pacientes, con capacidad para 6 personas sentadas y una silla de ruedas, con zona diferenciada para pacientes en camilla, con capacidad para 2 camillas, dotada de instalación de oxígeno y aparataje para toma de constantes vitales.
- Zona de Consultas externas: Próxima a la zona de quirófanos contará como mínimo con un local para consulta con sala de exploración diferenciada en el caso de que se presente oferta a un grupo de procedimientos quirúrgicos y al menos 2 locales de las mismas características si presenta oferta a más de un grupo de procedimientos quirúrgicos.
- Equipamiento específico para las consultas externas: Con la dotación específica y necesaria para realizar las exploraciones propias de la especialidad.
- Unidad de Hospitalización:
 - ✓ La Unidad de hospitalización será propia de la entidad ofertante o concertada por la misma, con un mínimo de 10 camas.
 - ✓ Todas las habitaciones estarán adecuadamente equipadas, con tomas de oxígeno y vacío, así como aseo en cada una de ellas. En la Autorización de funcionamiento del centro concertado donde se realice la hospitalización, deberá constar que dispone de Oferta asistencial para la especialidad a la que licita según el RD 1277/2003 de 10 de octubre.
- Instalaciones y equipamiento, propios de la entidad ofertante o concertados por la misma, necesarios para realización de pruebas diagnósticas de bioquímica y hematología.
- Instalaciones y equipamiento, propios de la entidad ofertante o concertados por la misma, necesarios para realización de pruebas diagnósticas de radiología convencional.
- Instalaciones y equipamiento, propios de la entidad ofertante o concertados por la misma, necesarios para la realización de pruebas diagnósticas de Anatomía Patológica.
- Aseo de pacientes.



El Centro dispondrá de instalación de calefacción y aire acondicionado, general o individual, en todas las zonas implicadas en la prestación del servicio.

8.1.3.2. El bloque quirúrgico deberá reunir las siguientes características.

Todos los locales relacionados con la actividad quirúrgica deberán estar agrupados en un área bien definida, apartada de la circulación general del hospital y controlada en sus entradas y salidas.

- Dispondrá del espacio suficiente para albergar las siguientes zonas, convenientemente coordinadas:
 - Control.
 - Vestuarios.
 - Salas de preanestesia, o lugar definido donde se realiza la preanestesia.
 - Quirófano/s.
 - Espacio para el lavado de manos con acceso directo al quirófano.
 - Sala de despertar o Unidad de reanimación posquirúrgica, anexa a los quirófanos.
 - Área de descanso de personal y servicios.
 - Esterilización de emergencia.
 - Almacenes de sucio y limpio.
 - Almacén de aparatos.
- Existirá una separación clara de la circulación de material limpio de la de sucio.
- Quirófano.
 - El Bloque tendrá, como mínimo, un quirófano completamente equipado.
 - El utillaje básico de un quirófano tipo será el siguiente:
 - ✓ Aspirador portátil.
 - ✓ Un desfibrilador.
 - ✓ Electroestimulador.
 - ✓ Equipo de Anestesiología y Reanimación que incluya respirador y monitorización de gases anestésicos.
 - ✓ Lámpara quirúrgica.
 - ✓ Mesa operatoria, auxiliar, de instrumental y de mayo.
 - ✓ Monitor Básico (Electrocardiograma/pulso).
 - ✓ Taburete, banquetas y cubo.
- ✓ Instalaciones:
 - Tomas de aire, oxígeno, protóxido de nitrógeno y vacío.
 - Protecciones de electricidad estática (normas de Industria).
 - Conexión a fuerza eléctrica alternativa con tiempo de latencia ajustado a las normas.
 - Negatoscopios y reloj con segundero y minuterio activables.
- ✓ Sala de despertar o de Reanimación posquirúrgica.
 - Anexa al quirófano, con capacidad mínima para 2 camas por quirófano.



- Existirán tomas de aire, oxígeno y vacío, así como de corriente eléctrica en cada cabecera de cama.
- Dispondrá de un equipo de monitorización por cama con al menos ECG, Saturación de O2 y tensión arterial no invasiva.
- Dispondrá de equipamiento completo para reanimación cardiopulmonar, incluyendo desfibrilador miocárdico.
- Dispondrá por cada cama de 2 canales de presión invasiva en el monitor, bombas de infusión con 4 líneas de infusión
- Cada dos camas un ventilador volumétrico
- Cada 4 camas un módulo CPAP y un calentador de sangre
- Para la Unidad: disponibilidad de soporte ventilatorio mecánico, un monitor y un respirador de transporte y radiología portátil
- ✓ Sala de adaptación al Medio: para los centros que realicen procedimientos quirúrgicos con Cirugía Mayor Ambulatoria. Contará con, al menos, dos camas con el mismo equipamiento que se señala para la URPA.
- ✓ Área de esterilización:
 - Lavadora apropiada para material quirúrgico.
 - Al menos, dos autoclaves dotados de registro de presión y temperatura y adaptados a la correspondiente Normativa UNE actualizada.
 - Para garantizar la calidad de la esterilización se llevará un registro de actividades y trazabilidad y un control rutinario de los procesos de esterilización con los parámetros físicos del ciclo y los indicadores químicos y biológicos.
 - Sistema de esterilización en frío para material termosensible.
 - Todas las actividades que componen el proceso de limpieza y desinfección de material deberán estar protocolizadas.
- En el bloque existirán normas escritas, aprobadas por la dirección del centro, sobre:
 - Asepsia, antisepsia y control bacteriológico.
 - Uniformación.
 - Circulación de personas y materiales.
 - Documentación y registros a cumplimentar, existiendo un responsable del cumplimiento de las mismas.
- El Bloque quirúrgico contará con un Libro de registro de la actividad quirúrgica donde, como mínimo, se recogerán los siguientes datos:
 - Número de orden correlativo.
 - Identificación del paciente.
 - Fecha de la intervención.
 - Diagnóstico.
 - Carácter programado o urgente de la intervención.
 - Hora de entrada y de salida al quirófano.
 - Nombre del Cirujano Jefe, Ayudantes (Cirujanos y otro personal sanitario) y del Anestesiista.



8.1.3.3. Servicio de limpieza y mantenimiento

La entidad concertada deberá disponer de los medios necesarios, propios o contratados, para garantizar la limpieza y mantenimiento de todas las instalaciones.

8.2. BLOQUE B. PERSONAL

8.2.1. Personal sanitario facultativo directamente relacionado con el procedimiento quirúrgico:

8.2.1.1. Titulación: El personal facultativo que realice los procedimientos quirúrgicos objeto del contrato deberá estar en posesión de la titulación de la especialidad, homologada por el Ministerio competente, correspondiente a cada uno de los grupos en los que participe.

8.2.1.2. Número mínimo:

- Para la realización de cada procedimiento quirúrgico el número necesario de facultativos especialistas será aquel que siguiendo los criterios científicos actuales en cada momento, garantice la adecuada efectividad del procedimiento quirúrgico con el mínimo riesgo para el paciente.
- En todo procedimiento quirúrgico con anestesia general, local o regional, será imprescindible la presencia de un facultativo especialista en Anestesiología y Reanimación durante la realización del mismo, que además será el responsable del paciente durante su estancia en la sala de despertar o de reanimación posquirúrgica.

8.2.1.3. Experiencia acreditada: El cirujano principal que realiza los procedimientos quirúrgicos objeto del contrato, deberá tener una experiencia hospitalaria mínima de 4 años en activo que acreditará mediante currículum.

8.2.1.4. Localización y disponibilidad: Para la atención de las complicaciones urgentes derivadas del procedimiento quirúrgico realizado, deberá haber el equipo de personal sanitario facultativo necesario y como mínimo un cirujano localizado y disponible al menos durante:

- Pacientes hospitalizados: el tiempo que permanezca el paciente en régimen de hospitalización hasta el alta hospitalaria.
- Procedimientos quirúrgicos realizados con Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA): las primeras 24 horas tras la realización del procedimiento quirúrgico, en el caso de que el paciente abandone, por orden facultativa, el centro concertado antes de las primeras 24 horas.
- Las complicaciones urgentes se atenderán en las instalaciones del centro concertado.



8.2.2. Personal sanitario no facultativo directamente relacionado con el procedimiento quirúrgico:

8.2.2.1. Titulación: El personal sanitario no facultativo que intervenga en los procedimientos quirúrgicos objeto del contrato deberá estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario en Enfermería o equivalente.

8.2.2.2. Número mínimo: En cada procedimiento quirúrgico habrá al menos un enfermero/a.

8.2.2.3. Experiencia acreditada: Una experiencia hospitalaria mínima de 1 año en activo que acreditará mediante currículum como enfermero/a instrumentista de quirófano, en la realización de los procedimientos quirúrgicos objeto del contrato, que acreditará mediante currículum.

8.2.2.4. Localización y disponibilidad: Para la atención de las complicaciones urgentes derivadas del procedimiento quirúrgico realizado deberá haber un enfermero localizado y disponible al menos durante:

- Pacientes hospitalizados: el tiempo que permanezca el paciente en régimen de hospitalización hasta el alta hospitalaria.
- Procedimientos quirúrgicos realizados con Cirugía Mayor ambulatoria (CMA) las primeras 24 horas tras la realización del procedimiento quirúrgico, en el caso de que el paciente abandone, por orden facultativa, el centro concertado, antes de las primeras 24 horas.

8.2.3. Personal Sanitario que interviene en la prestación del servicio pero no directamente en la realización del procedimiento quirúrgico:

El personal facultativo y de enfermería reunirá las características que se definen en los apartados siguientes:

8.2.3.1. Personal sanitario facultativo:

- Al frente de cada una de las unidades especificadas en el Bloque anterior (A), tanto propias de la entidad contratada como concertadas por ésta, deberá existir un facultativo con la especialidad correspondiente según establecen la Comisión Nacional de Especialidades y las directrices del conocimiento científico actualizado. Así mismo en cada una de ellas habrá el número de facultativos especialistas, con la disponibilidad necesaria y durante el tiempo suficiente para que según sea el nivel de actividad desarrollada, y siguiendo los mismos criterios científicos, se garantice la adecuada efectividad del servicio asistencial que se realice, con el mínimo riesgo para el paciente.
- En todas las unidades se prestará la atención sanitaria adecuada por personal capacitado durante las 24 horas del día.
- La Unidad de Cuidados Intensivos (si la hubiere) contará al menos con un facultativo especialista en Medicina Intensiva de presencia física las 24 horas



del día y la Unidad de Hospitalización contará con un facultativo especialista en Medicina Interna, de presencia física en horario de mañana y localizado en horario de tarde y noche.

8.2.3.2. Personal sanitario no facultativo: En cada una de las unidades especificadas en el Bloque anterior (A), tanto propias de la entidad contratada como concertadas por ésta, deberá existir el personal sanitario no facultativo (Enfermero/a, TER, Auxiliar de enfermería, etc.) que, cumpliendo con la normativa vigente y las directrices científicas actualizadas, asegure la adecuada atención al paciente en cada una de ellas.

- Unidad de Hospitalización:
 - Enfermero/a: 1 por cada 8 camas o fracción en turno de mañana y tarde y 1 por cada 16 camas o fracción en turno de noche.
 - Auxiliar de enfermería: 1 por cada 16 camas o fracción en turno de mañana y tarde y 1 por cada 30 camas o fracción en turno de noche.
 - En todos los casos, un mínimo de 1 enfermero/a y 1 auxiliar de enfermería, prestarán asistencia sanitaria en la unidad de hospitalización durante las 24 horas. Se deberá justificar para cada categoría la relación laboral o de servicios con la empresa donde se reflejen 168 horas semanales del personal de enfermería y auxiliar de enfermería con la empresa y establecimiento sanitario.

8.2.4. Requisitos Específicos de Grupo para el personal sanitario facultativo directamente relacionado con el procedimiento quirúrgico:

8.2.4.1. Titulación: el personal facultativo que realice los procedimientos quirúrgicos objeto del contrato deberá estar en posesión de la titulación de la especialidad, homologada por el Ministerio competente, correspondiente a cada uno de los grupos en los que participe.

8.2.4.2. Número mínimo:

- En los procedimientos quirúrgicos el **número mínimo será de un cirujano** con la especialidad correspondiente en cada grupo.
- En los procedimientos quirúrgicos de sustitución de rodilla y cadera, **el número mínimo e imprescindible será siempre de dos: un cirujano jefe y un cirujano ayudante.**

8.3. BLOQUE C. ORGANIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

8.3.1. Horario de Servicio: Con carácter general el servicio se prestará de lunes a viernes. Cualquier modificación a este horario, deberá ser notificada previamente por el centro concertado y autorizada por el centro contratante. Durante el horario establecido en los dos apartados



anteriores, se realizarán los procedimientos quirúrgicos incluidos en los lotes objeto del servicio a pacientes en régimen ambulatorio, hospitalizados y situaciones de urgencia, según determine el centro contratante.

8.3.2. Recepción de la solicitud de realización del procedimiento quirúrgico:

- Para la solicitud de concertación del procedimiento quirúrgico incluido en cada lote, el centro contratante utilizará un sistema de solicitud electrónica generada desde su sistema de información y enviada en forma de lista de trabajo, a través de internet u otra conexión equivalente, al centro concertado.
- El centro concertado estará obligado a adecuar su sistema de recepción de solicitudes, sin coste para el centro contratante, de forma que acepte correctamente las listas de trabajo remitidas por éste.
- En la solicitud vendrán reflejados todos los datos demográficos y clínicos pertinentes.

8.3.3. Comunicación de la fecha de realización del procedimiento quirúrgico (citación):

Para la citación del procedimiento quirúrgico con carácter general:

- Pacientes en régimen ambulatorio: la entidad adjudicataria realizará la citación, en un plazo no superior a dos días laborables, desde la recepción de la información, directamente al paciente por vía telefónica.
- Pacientes hospitalizados: la entidad adjudicataria realizará la citación, en un plazo no superior a 1 día laborable, desde la recepción de la información, directamente al paciente por vía telefónica.
- Pacientes urgentes: la entidad adjudicataria contactará vía telefónica a tiempo real en la dependencia o dependencias del centro contratante que éste determine.

Cuando no sea posible contactar con el paciente o con personas más próximas a él, tras tres llamadas telefónicas infructuosas (una de ellas al menos por la tarde) y en ausencia de respuesta en el plazo de tres días laborables a la carta, con acuse de recibo, o al burofax, la entidad adjudicataria comunicará al centro contratante por el procedimiento que éste determine, los pacientes que no hayan sido localizados, adjuntando las justificaciones del intento de localización.

Cuando la comunicación si sea posible, la demora en la citación para la realización del tratamiento se ajustará a los plazos descritos previamente.

8.3.4. Realización del procedimiento quirúrgico.

- Las demoras máximas en el inicio del procedimiento quirúrgico incluido en cada lote, contadas desde la fecha de recepción de la solicitud por el centro concertado, serán las siguientes (salvo que se especifique una fecha concreta posterior en la solicitud):
 - En pacientes con carácter urgente con la mayor brevedad posible y un plazo máximo de respuesta de 4 horas.



- En pacientes hospitalizados 2 días laborables.
- En pacientes en régimen ambulatorio 5 días laborables desde la recepción de la solicitud por la entidad adjudicataria hasta el inicio del procedimiento quirúrgico.
- Desde el inicio del procedimiento quirúrgico (consulta de valoración, preoperatorio y consulta de preanestesia) hasta la realización del acto quirúrgico no transcurrirán más de:
 - En pacientes con carácter urgente 24 horas.
 - En pacientes hospitalizados 5 días laborables.
 - En pacientes en régimen ambulatorio 7 días laborables.

8.3.5. Sistemas de información y comunicación:

Las Normas de manejo de la información clínica por parte de la entidad adjudicataria se adecuarán a la normativa (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de Información y documentación clínica).

Asimismo el adjudicatario dispondrá de un sistema de archivo de documentación clínica que garantice la seguridad de la información desde el punto de vista de integridad, en y disponibilidad y el cumplimiento de la legislación vigente en cada momento durante el plazo de ejecución del contrato relativa a la protección de datos de carácter personal.

El adjudicatario del presente contrato deberá observar los principios y disposiciones exigibles por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril del 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos en materia de protección de datos, así como del resto de legislación estatal y autonómica aplicable a esta materia, en concreto a lo establecido en la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y las exigencias recogidas en la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de Información y documentación clínica y la Ley 8/2003, de 8 abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud.

El adjudicatario se compromete a tratar dichos datos personales observando los principios exigibles por la legislación vigente en materia de protección de datos, en particular los relativos a la calidad de los datos, seguridad de los mismos y deber de secreto, así como a cumplir las instrucciones recibidas de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, no utilizando dichos datos con finalidades distintas a las especificadas.

El adjudicatario deberá conservar el secreto profesional respecto de los datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento de



los servicios prestados, no comunicando a ningún tercero ni siquiera para su conservación, los datos facilitados por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, como responsable del tratamiento de los datos.

El adjudicatario, una vez cumplida la responsabilidad contractual, se compromete a devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación.

No obstante, la entidad adjudicataria mantendrá archivada copia de los informes clínicos de resultados a disposición del centro contratante, un mínimo de 5 años con los datos debidamente bloqueados, para el cumplimiento de la normativa relativa a conservación de datos de historias clínicas.

8.3.6. Sistema de gestión de solicitudes del procedimiento quirúrgico y de informes:

La gestión de solicitud del procedimiento quirúrgico y envío de informes se articularán sobre soportes de papel cuando el Complejo Asistencial de Segovia así lo requiera. La entidad adjudicataria estará en condiciones, siempre que el centro contratante lo requiera, de recibir las solicitudes de realización de procedimiento quirúrgico y de remitir los informes resultantes en formato electrónico y conforme a los estándares habituales en aplicaciones médicas.

8.3.6.1. Recepción de solicitudes

- Cuando se opte por el soporte en papel, la entidad adjudicataria admitirá las solicitudes de realización del procedimiento quirúrgico en los impresos que el centro contratante determine, en los cuales vendrán reflejados todos los datos demográficos y clínicos pertinentes.
- Cuando el Complejo Asistencial de Segovia lo requiera, el sistema de información de la entidad adjudicataria será capaz de recibir del sistema de información del centro contratante la lista de trabajo y los datos de los pacientes. El sistema de información de pacientes citados, aportado por el Complejo Asistencial de Segovia, contendrá detalles de los pacientes y del procedimiento quirúrgico solicitado, evitando la necesidad de introducir esa información en los equipos.
- El sistema de información de la entidad adjudicataria preservará los datos demográficos del paciente, y también el número de historia y otros identificadores como número de acceso y similares, de modo que puedan ser devueltos asociados a las imágenes e informes que resulten de la realización del procedimiento quirúrgico.

8.3.6.2. Formato y transmisión de los informes

- Los informes generados por la entidad adjudicataria se adecuarán a un modelo consensado con el Complejo Asistencial de Segovia y que facilite su utilización posterior a efectos de codificación, seguimiento, etc.
- Cuando el Complejo Asistencial de Segovia opte por un formato electrónico bien sea para su transmisión electrónica o para su incorporación a un CD/DVD, los informes compartirán la misma vía de envío. En tales casos, el formato



electrónico de los mismos habrá de ser uno de alta compatibilidad y adecuado para su fácil incorporación al sistema de incorporación de dicho centro.

- Los informes preservarán fielmente todos los datos demográficos del paciente, el número de historia y otros identificadores.

8.4. BLOQUE D. INFORME CLÍNICO DE RESULTADOS

8.4.1. Contenido del Informe clínico definitivo: Siempre se realizará tras el alta hospitalaria. Se entregará el original al paciente y se remitirá copia al Complejo Asistencial de Segovia. Deberá Incluir como mínimo:

- Datos de identificación del paciente.
- Resumen de historia clínica (antecedentes, anamnesis, exploración física completa y exploraciones complementarias realizadas antes de la cirugía).
- Diagnóstico preoperatorio: Proceso que motiva el procedimiento quirúrgico realizado.
- Copia, perfectamente legible, del documento de consentimiento informado, adecuadamente cumplimentado.
- Protocolo de realización del procedimiento quirúrgico.
- Protocolo clínico con inclusión de consultas de preanestesia y prequirúrgica.
- Protocolo de ejecución: con indicación de la Técnica Quirúrgica.
- Incidencias durante la realización del procedimiento quirúrgico (si las hubiere).
- Situación del paciente al alta.
- Recomendaciones diagnóstico-terapéuticas relacionadas o no con el proceso objeto del servicio. En el caso de prescripción de medicamentos, se detallará el nombre del medicamento, su forma farmacéutica, posología y duración de la pauta.
- Datos de identificación del especialista que realice el informe, con su sello, número de colegiado y firma del mismo.
- Fecha de la próxima de revisión en consulta posthospitalaria.
- Especificación de la manera más detallada posible del tipo y marca de prótesis o cualquier otro material implantado. La elección del tipo de prótesis deberá contar con la aprobación o visto bueno por escrito, del centro contratante de Sacyl, previa consulta con el hospital de referencia.
- En el informe de alta hospitalaria, constará el teléfono del centro concertado, haciendo mención expresa de que la atención de complicaciones o situaciones de urgencia derivadas del procedimiento quirúrgico realizado se hará en las instalaciones del centro concertado donde se realizó el procedimiento quirúrgico.

8.4.2. Informe tras consulta externa posthospitalaria: Tras las consultas de control posthospitalario se entregarán tanto al paciente como al Complejo Asistencial de Segovia, los informes pertinentes incluyendo, si hubiera, el de Anatomía Patológica.



8.4.3. Demoras en la entrega del informe:

- Al paciente: los informes se entregarán al alta y tras las consultas posthospitalarias.
- Al hospital de referencia: en un plazo no superior a 3 días laborables tras el alta hospitalaria del paciente y las consultas posthospitalarias, una vez recibidos los informes pendientes (Anatomía Patológica).

8.4.4. Soporte del Informe:

- Cuando el Complejo Asistencial de Segovia opte por un formato electrónico, bien sea para su transmisión electrónica o para su incorporación a un CD o un DVD, los informes compartirán el mismo tipo de soporte y la misma vía de envío, como se especifica en el apartado 7.3.5.2.
- El Complejo Asistencial de Segovia podrá optar alternativamente (si se requiere) por informe escrito, acompañado de la documentación gráfica, en soporte convencional y/o digital, de las exploraciones realizadas, con los datos de Identificación del paciente impresos.

8.4.5. Procedimiento de entrega:

- El envío de informes e imágenes se realizará por sistemas de red de transmisión segura, si así lo solicita el Complejo Asistencial de Segovia.
- Los informes escritos así como la documentación gráfica (radiografías, etc), y si lo requiere el Complejo Asistencial de Segovia, el CD o DVD, serán entregados, físicamente por personal de la entidad adjudicataria o servicio de mensajería de ésta dependiente, para su custodia en el archivo de historias clínicas. El Informe clínico definitivo podrá ser adelantado vía electrónica.
- Al Complejo Asistencial de Segovia, se le informará mensualmente (el último día laborable de cada mes) por parte del centro adjudicatario, un listado resumen de los pacientes intervenidos, los procedimientos quirúrgicos realizados y de los informes enviados.

8.4.6. Archivo de informes: La entidad adjudicataria mantendrá archivada copia de los informes clínicos de resultados a disposición del centro contratante, un mínimo de 5 años.

8.4.7. Consentimiento informado: La empresa adjudicataria dispondrá de hojas de consentimiento informado. En el informe clínico definitivo deberá constar el consentimiento informado firmado por el paciente o persona responsable del mismo. El Complejo Asistencial de Segovia podrá solicitar y tener acceso en cualquier momento a una copia de dicho consentimiento, y si se precisa será enviado por los medios tecnológicos cifrados ya descritos.

8.4.8. Hoja informativa y de reclamaciones: Se entregará una "hoja informativa" a cada paciente, en la que se harán constar los derechos y obligaciones del paciente y de la entidad contratada. Igualmente se informará del mecanismo y soporte de las reclamaciones y sugerencias.



Deberán disponer de hojas de reclamaciones según establece el Decreto 40/2003 de 3 de abril, relativo a las Guías de información al usuario y a los procedimientos de reclamación y sugerencia en el ámbito sanitario.

8.5. BLOQUE E. REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

8.5.1. La realización de cada procedimiento quirúrgico seguirá el siguiente protocolo general:

8.5.1.1. Consulta Externa de Valoración por la especialidad correspondiente. En la misma se realizará anamnesis, exploración física completa y todas las exploraciones complementarias necesarias, rutinarias o especiales, y/o procedimientos terapéuticos previos a la realización del procedimiento quirúrgico específico, incluido el estudio preoperatorio.

8.5.1.2. Consulta de Preanestesia. Siempre que no se haya realizado en el hospital de origen del paciente. Se podrá realizar el mismo o en día distinto que la anterior.

8.5.1.3. Consentimiento Informado para la realización del procedimiento quirúrgico: firmado por el paciente o persona legalmente autorizada, previa información detallada de las posibles consecuencias del mismo. Se realizará en cualquiera de las consultas anteriores.

8.5.1.4. En los casos que tengan la consideración de "urgentes" la valoración y obtención del consentimiento informado, se realizará con la mayor brevedad posible, antes de la realización del procedimiento quirúrgico.

8.5.1.5. Preparación para la realización del procedimiento quirúrgico en régimen ambulatorio o en hospitalización según las características de cada caso.

8.5.1.6. Realización del procedimiento quirúrgico: En los supuestos en los que así conste, se seguirá la técnica quirúrgica indicada en la solicitud del procedimiento quirúrgico.

8.5.1.7. Ingreso en Unidad de Despertar, Unidad de Reanimación Posquirúrgica y/o Unidad de Hospitalización convencional: El paciente deberá permanecer en el centro sanitario ofertante el tiempo mínimo necesario que, para cada procedimiento, situación del paciente y criterios científicos establecidos, asegure la mayor efectividad terapéutica y el menor riesgo para el paciente.

8.5.1.8. Consultas de control posthospitalarias

- Siempre se realizarán las necesarias para cada caso y que estén relacionadas con el proceso quirúrgico por el que fue intervenido, y en todos los casos, un mínimo de dos (2) consultas de control.
- En cada una de estas consultas de control, se realizarán todas las exploraciones complementarias (rutinarias o especiales) y/o procedimientos complementarios (terapéuticos y/o diagnósticos) que se consideren necesarios por estar relacionados con el procedimiento realizado. La citación y realización de estas



exploraciones y/o procedimientos, correrán bajo responsabilidad y cobertura del centro adjudicatario

- Si el paciente intervenido solicita atención ambulatoria programada al Complejo Asistencial de Segovia, por cualquiera de las vías de acceso existentes. Y se identifica que el motivo de consulta, está relacionado con el proceso quirúrgico por el que fue intervenido en el centro adjudicatario, el Complejo Asistencial de Segovia notificará a dicho centro de la situación, por vía electrónica y/o telefónica, según lo establezca el centro adjudicatario. El centro adjudicatario tras recepción del caso, citará al paciente para su valoración en un máximo de 5 días laborables, y comunicará vía electrónica al Complejo Asistencial de Segovia y telefónicamente al paciente, la fecha de la citación y las recomendaciones que corresponda. Una vez efectuada dicha valoración, el centro adjudicatario enviará al Complejo Asistencial de Segovia por vía electrónica, el informe clínico correspondiente que incluya el juicio diagnóstico, la evolución del proceso quirúrgico y la conducta a tomar.

8.5.1.9. Servicios incluidos: En la realización del procedimiento se consideran incluidos, todos los servicios especificados anteriormente, además de los que se citan a continuación:

- Las pruebas preoperatorias (analíticas y de imagen), que en la valoración anestésica se consideren necesarias, siempre y cuando éstas ya no estén realizadas ya por el Complejo Asistencial de Segovia, en el momento de la solicitud.
- El tratamiento farmacológico que se requiera durante el proceso, así como la sangre y hemoderivados.
- Curas.
- Alimentación incluídas nutrición enteral y parenteral.
- Asistencia por equipo médico especializado, enfermería y personal auxiliar sanitario.
- La utilización de quirófano y anestesia si se precisa.
- Las pruebas analíticas de control postquirúrgico que se requieran (por ejemplo: seminograma de control en pacientes intervenidos de vasectomía)
- Informe de anatomía patológica.
- El material fungible necesario y los controles preoperatorios y postoperatorios, incluidos aquellos que se realicen en régimen ambulatorio.
- Material protésico. La elección de la prótesis a implantar deberá contar con la aprobación previa o visto bueno, por escrito, del Complejo Asistencial de Segovia. En todos los procedimientos en los que se implante una prótesis, la entidad ofertante, especificará en la oferta de licitación del procedimiento negociado el tipo de prótesis, marca, precio y técnica quirúrgica de implantación.

8.5.2. Material protésico – Selección de Prótesis

En todos los procedimientos quirúrgicos en los que se implante una prótesis, la entidad ofertante especificará en la oferta de licitación los tipos de prótesis ofertados (marca, modelo y técnica quirúrgica de implantación).



En la selección del tipo de prótesis, se utilizarán como requisitos mínimos los criterios que se definen a continuación. Estos criterios pueden ser modificados siguiendo la evolución del conocimiento científico, con el objetivo de proporcionar la máxima calidad y el menor riesgo al paciente y siempre con la aprobación del centro de gasto contratante del SACYL.

8.5.2.1. Selección del tipo de implante en prótesis de rodilla. La selección del implante buscará proporcionar a cada paciente la máxima calidad.

- Prótesis Unicompartimentales:
 - Femoro-tibiales: la indicación de este tipo de prótesis debe cumplir los siguientes requisitos:
 - ✓ Afectación de un solo compartimento femorotibial
 - ✓ Comprobación en el acto quirúrgico de la integridad de los otros compartimentos.
 - ✓ Diagnóstico que permita establecer que la afectación no se va a extender a otros compartimentos en un plazo de tiempo breve.
 - ✓ Femoro-patelares: se desaconseja la utilización de los mismos.
- Prótesis bicompartimentales: Se trata de la técnica más habitual y comprende la sustitución de los compartimentos fémoro-tibiales. Estará indicada en todos aquellos casos de afectación generalizada de la rodilla.
- Prótesis tricompartmentales: Se entiende por prótesis tricompartmentales la inclusión del implante rotuliano en una prótesis bicompartimental. La utilización de implantes de rótula para la articulación fémoro-patelar es un tema en el que no hay consenso definido.

8.5.2.2. Tipo de fijación

- Componente femoral: se deja a la libre elección del cirujano, quien basará ésta en la evaluación de otros factores, según los criterios actuales, calidad ósea, esperanza de vida, actividad postoperatoria prevista y relación coste eficacia.
- Componente tibial: se considera práctica aconsejable la cementación en todas las ocasiones dejando como excepción aquellos casos de pacientes más jóvenes con muy buena calidad ósea y sin grandes alteraciones axiales. En estos casos toma especial importancia la utilización de otros sistemas complementarios de fijación y estabilización del platillo tibial, como son los tornillos y los vástagos tibiales.
- Componente rotuliano: se recomienda siempre la utilización de implantes sin respaldo metálico y fijación cementada.

8.5.2.3. Recomendaciones Especiales

- El espesor de polietileno de los platillos tibiales es un factor importante a la hora de asegurar la duración del implante por lo que se recomienda no utilizar espesores menores de 8mm.
- La realización de una buena técnica quirúrgica es especialmente importante en el caso de prótesis de rodilla ya que las deficiencias en la correcta colocación del implante, especialmente en lo que la alineación se refiere, conduce rápidamente a un fracaso de éste por aflojamiento o desgaste. Se debe tener en cuenta que las reintervenciones de rescate, en el caso de la rodilla, son



extremadamente complicadas y pueden conducir a situaciones muy invalidantes.

- Se considera imprescindible para la correcta planificación de la técnica quirúrgica la realización siempre de estudio radiográfico de ambas rodillas en carga, así como radiografías axiales de rótula a 45°.

8.5.2.4. Selección del tipo de implante en prótesis de prótesis de cadera

- La selección del implante buscará proporcionar a cada paciente la máxima calidad. Los factores que están relacionados con el éxito o fracaso del implantes son: la edad, peso, actividad prevista, estado de salud y calidad ósea. Siendo la decisión el resultado de la valoración global del paciente.
- Respecto a la edad, es la esperanza de vida del paciente la que condiciona la selección. Respecto al peso, a mayor peso absoluto, mayor demanda mecánica. A mayor actividad prevista tras la cirugía, existirá una demanda mecánica más alta. La calidad del hueso es determinante para la elección del tipo de fijación de la prótesis.

8.6. OTRAS CONSIDERACIONES

- Hospitalización en habitación compartida o individual cuando sea preciso por las especiales circunstancias del paciente.
- Estancias en la Unidad de Cuidados Intensivos que pudiera precisar.
- El traslado forzoso de un paciente en transporte sanitario adecuado cuando por razones clínicas insuperables para la entidad contratada, derivadas de la propia intervención quirúrgica que motivó el ingreso del paciente o de complicaciones ajenas al proceso, surgidas después del ingreso y previa puesta en conocimiento del Complejo Asistencial de Segovia, sea necesaria su remisión al hospital de área correspondiente, los gastos generados al hospital de referencia, correrán igualmente a cargo de la entidad adjudicataria.
- Los costes derivados de las posibles complicaciones que pudieran presentarse a lo largo de todo el proceso asistencial, tanto en la fase preoperatoria como en la intervención quirúrgica propiamente dicha y en el postoperatorio, correrán, siempre que estén relacionadas con la prestación del servicio y/o el procedimiento realizado, a cargo de la entidad adjudicataria.
- Correrán igualmente a cargo de la entidad adjudicataria las consultas y el tratamiento de las complicaciones, urgentes o no, secundarias al procedimiento quirúrgico así como las reintervenciones necesarias, siempre que estén relacionadas con la prestación del servicio y/o el procedimiento realizado, y se produzcan o se indiquen en un plazo de tiempo no superior a dos años a contar desde el día siguiente a producirse el alta hospitalaria haciendo mención expresa de ello en el informe de alta.
- Se realizará rehabilitación precoz durante el ingreso hospitalario en los procedimientos que lo requieran y el informe de alta recogerá las recomendaciones de continuación de fisioterapia ambulatoria, en los casos en los que se precise, tanto en número de sesiones previsto, como la duración y el contenido de las mismas.



- Si el equipo quirúrgico del centro concertado estimase que por razones médicas detectadas en el estudio preoperatorio, no procede la intervención quirúrgica de un paciente, o el procedimiento indicado no es correcto, el centro concertado no lo realizará y el paciente será remitido de nuevo al Complejo Asistencial de Segovia con un informe motivado en el que se indiquen las causas por las que no se realiza el procedimiento solicitado. No se considerarán causa justificada de exclusión de pacientes los siguientes motivos:
 - Complejidad de la cirugía
 - Número de dedos a intervenir (en el caso de Hallux valgus)
 - Coexistencia de otras enfermedades asociadas o de tratamientos activos (anticoagulantes)
- Si el cambio de indicación sobreviene durante el acto quirúrgico, el equipo facultativo completará la cirugía que resulte precisa a su leal entender, liquidándose económicamente la cirugía practicada, con reserva para Sacyl de la facultad de recusar los cargos que, bajo criterios técnicos, obedezcan a causas manifiestamente previsibles, evitables o sean imputables a la pericia del equipo quirúrgico.
- Para todos los procedimientos que se realicen con cirugía mayor ambulatoria (CMA) el centro concertado deberá presentar un "Protocolo de realización de CMA".
- En el caso del lote de Cirugía General y Aparato Digestivo, si la tasa de recidiva herniaria fuera superior al 3%, el centro adjudicatario debe hacerse cargo de la reintervención (hasta alcanzar el número de pacientes que corresponda según la desviación observada).

9. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS MEDIANTE ENDOSCOPIA (COLONOSCOPIAS) LOTE 6

9.1. BLOQUE A. EQUIPAMIENTO

9.1.1. Normativa:

Será de obligado cumplimiento, en todo momento, la normativa legal local, autonómica y estatal vigente, para la construcción, ubicación, puesta en marcha y funcionamiento de este tipo de instalaciones, así como para la ubicación y funcionamiento de todos los equipos disponibles, electromédicos o no, y para todo el material fungible utilizado. Se ajustará a la normativa estatal del Real Decreto 1591/2009 por el que se regulan los productos sanitarios y marca CE) y de todos los equipos utilizados, electromédicos o no, y para todo el material fungible que se precise, debiendo estar todos ellos validados y en correcto estado de funcionamiento. Se deberá disponer de las correspondientes licencias y/o autorizaciones emitidas por las pertinentes administraciones u organismos.



9.1.2. Equipamiento Sanitario

- Unidad torre de endoscopia, compuesta por:
 - Procesador, fuente de luz HD y Monitor.
 - Procesador con capacidad para proporcionar imágenes de alta definición (Full HD 1080 líneas)
 - Disponer de sistemas ópticos y que permitan el realce del patrón vascular y de sistemas electrónicos para el realce de la mucosa.
 - Memoria USB compatible para la captura de imágenes.
 - Sistema de iluminación mediante lámpara Xenon de 300W o led de 4 focos, potencia con ajuste automático y manual de exposición de la luz, y lámpara de emergencia con cambio automático
 - Temperatura de color mínima de 6000°K e indicador de tiempo de lámpara encendida
 - Conexión electrónica rápida de endoscopios en un paso
 - Función de pre-congelado de alta calidad y que permita escalado de imagen a HD
 - Salidas de video analógico RGB, S- VHS y video compuesto. Salidas de video digital HD-SDI (2 salidas) y video compuesto
 - Monitor de alta definición compatible con los videocolonoscopios de la Unidad. Se dispondrá de sistema de almacenamiento de las imágenes, en sistema analógico y/o digital durante 8 años.
 - Otros. Existirá el instrumental necesario para la realización, en las mejores condiciones de eficacia y seguridad para el paciente, biopsias, extracción de cuerpos extraños de tamaño compatible con el del canal de instrumentación del endoscopio, instalación de líquido, etc.
- Videocolonoscopios. Se dispondrá de dos unidades de Videocolonoscopio flexible, con sistema de visión de fibra de vidrio. Estas unidades dispondrán de los siguientes elementos y características:
 - Obtención de imágenes full HD 1080
 - Longitud de trabajo al menos 1650 mm
 - Diámetro del extremo distal < 13,3 mm
 - Canal de trabajo con diámetro mínimo de 3,7 mm
 - Angulo de visión de 170° en visión normal.
 - Sistemas ópticos (con cambio de luz) y electrónicos que permitan el realce de patrones vasculares y otras estructuras de la mucosa.
 - Capacidad de variar la rigidez del endoscopio por el usuario en al menos 3 rigideces
 - Conector estanco de un solo paso
 - Doble foco óptico que permita seleccionar 2 enfoques distintos, en que la observación se optimice en campo cercano o lejano con ángulo de visión de al menos 160° en cercano.
 - Compatible con alguna de las torres de la Unidad.
- Electrobisturí. Aparato de electrocirugía que permita la técnica monopolar y bipolar que mediante el corte, la coagulación y la desvitalización electroquirúrgicas permitan el tratamiento endoscópico enfermedades del tracto



gastrointestinal. Debe contar con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

- Deberá incluir distintos programas de corte y coagulación para endoscopia flexible.
- Deberá tener sistema de seguridad de placa paciente monitorizado en todo momento de la utilización
- Posibilidad de variar la distancia de corte, cantidad de coagulación y velocidad de corte
- Deberá poder modular las distintas energías de corte y coagulación
- Dispondrá de programas de corte mono polar y bipolar para endoscopia flexible.

9.1.3. Equipamiento Endoscópico accesorio. Todos los accesorios utilizados en la práctica endoscópica para fines diagnósticos y/o terapéuticos y puede ser de un único uso (recomendado por la ESGE/ESGENA) o esterilizados tras realizar una cuidadosa limpieza mecánica. Este material debe incluir:

- Aguja de esclerosis,
- Pinzas de biopsia,
- Asas de polipectomía de distintos diámetros,
- Pinzas/Cestas para recuperar pólipos,
- Clips Hemostáticos,
- Sonda Bipolar,
- Tinta para tatuaje,
- Pinzas para extracción de cuerpos extraños.

9.1.4. Sala de Desinfección. Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:

- Ubicación independiente de las salas de exploración.
- Varios fregaderos con profundidad y tamaño adecuados para el lavado y separados entre sí.
- Existencia de máquinas/lavadoras de desinfección automática.
- Espacio para el almacenamiento de los productos químicos.

9.1.5. Equipamiento General. Se deberá disponer de:

- Farmacopea (oxígeno, bicarbonato, adrenalina, atropina, lidocaína, dopamina, dobutamina y aleudrina, etc.) y equipamiento completo de reanimación cardiopulmonar (carro de RCP) incluyendo desfibrilador miocárdico, laringoscopio, tubos orotraqueales, vías venosas centrales y pulmonares, bolsa de resucitación unidireccional, etc.
- Oxigenoterapia, sistemas de vacío y aire comprimido, con mascarilla y gafas nasales adecuadas al paciente.
- Refrigerador convencional con registro gráfico de temperatura, para almacenamiento de material (fármacos, etc).
- Material habitual de curas (agua oxigenada, alcohol, antisépticos, compresa estériles, esparadrapo de papel y tela, gasa hidrófila, gasa hidrófila estéril, hibitane o similar, etc.).



- Equipamiento informático adecuado a las necesidades de la prestación concertadas

9.1.6. Equipamiento Informático

- Hardware: Un ordenador con procesador Pentium IV ó equivalente a 3GHz, memoria RAM 256 Mb y disco duro de 40 Gb.
- Software: Programa de Gestión de endoscopias que permita realizar y almacenar informes e imágenes endoscópicas.

9.1.7. Otro equipamiento

- Mobiliario general habitual en este tipo de instalaciones.
- Material de limpieza y aseo (bolsas de plástico para eliminar desechos, detergente, jabón, lejía concentrada, etc.).

9.1.8. Seguridad y Mantenimiento. La entidad ofertante dispondrá de servicio técnico permanente y de mantenimiento (preventivo y reparador), estableciendo, en este sentido, las condiciones de colaboración con las empresas suministradoras para reducir al mínimo los tiempos de parada del equipo (tiempo máximo de parada dos días laborables), e igualmente, la entidad ofertante se responsabilizará de la garantía de calidad de funcionamiento, de acuerdo con las instrucciones de cada suministrador y del restablecimiento de las condiciones que, aun no suponiendo un paro en la actividad, puedan comprometer la calidad de las exploraciones y/o la seguridad de los pacientes.

9.2. BLOQUE B. LOCALES E INSTALACIONES

Será de obligado cumplimiento la normativa legal local, autonómica y estatal vigente, para la construcción y puesta en marcha de este tipo de Instalaciones, así como las normas de general aplicación.

9.2.1. Ausencia de barreras arquitectónicas. No existirán barreras arquitectónicas en acceso a:

- Edificio: Permitirá acceso de vehículos de transporte sanitario.
- Instalaciones y Sala de exploración: Permitirá acceso y desplazamiento de pacientes en camilla y sillas de ruedas.

9.2.2. Locales y dependencias

- **Zona de recepción /admisión de pacientes y acompañantes.**

- Permitirá la realización de las funciones de atención e información al usuario, planificación de pruebas., control de asistencia de los pacientes, procesos administrativos del servicio y atención telefónica. Posibilidad de informar a personas tanto con movilidad normal como reducida (silla de ruedas o camilla).



- Ha de estar emplazada a la entrada del centro, en lugar visible y estratégico para que pueda ser vista por cualquier persona que entre.
- **Secretaría y área administrativa.** Existirá el equipamiento necesario para:
 - Realización y envío de informes de resultados.
 - Archivo de informes en soporte informático.
 - Archivo de informes e historia clínica en soporte convencional.
- **Sala de espera.** Superficie de 10m² para pacientes y acompañantes, con capacidad para 8 personas sentadas, permitiendo la entrada y estacionamiento de dos sillas de ruedas o camillas.
- **Sala de Endoscopia.** Existirá, una zona específica y diferenciada para la realización del procedimiento endoscópico, con una superficie de 12 m². Esta zona estará dotada de lavamanos.
 - Anexada a esta zona o independiente existirá otra destinada al mantenimiento, desinfección y esterilización adecuadas de todo el instrumental necesario, para lo cual se seguirán los principios establecidos por el conocimiento científico actualizado y recomendado por las sociedades científicas de la/s especialidad/es correspondiente/s.
 - Deberá existir una cabina/vestuario para el paciente ó una zona independizada que sirva para esta función.
- **Sala de recuperación postanestésica.** Existirá, una zona específica y diferenciada para la recuperación postanestésica, con capacidad para al menos tres camas.
- **Vestuarios y aseos.**
 - Aseos públicos, con lavabo e inodoro, diferenciado para mujeres y otro para hombres.
 - Aseo público para discapacitados físicos. Deberá disponer de lavabo e inodoro y de todo el equipamiento básico para discapacitados físicos que establezca la normativa legal vigente, en cada momento.
 - Vestuario y usuarios. Área diferenciada. Esta área podrá ser independiente o estar integrado/anexo al local de consulta o al área de exploraciones funcionales.
 - Vestuario y aseo de personal: Existirá un vestuario y un aseo para uso del personal.
- **Archivo.** Espacio destinado para archivo de historias clínicas. Deberá garantizar la privacidad y seguridad de los documentos.
- **Almacén.** Zona de almacén de material y medicamentos.

9.2.3. Aspectos Generales. Instalación de un sistema de aire acondicionado y calefacción.



- 9.2.4. Servicios de limpieza y mantenimiento.** La entidad contratada deberá disponer de los medios necesarios, propios o contratados, para garantiza la limpieza y mantenimiento de todas las instalaciones.

9.3. BLOQUE C. RECURSOS HUMANOS

- 9.3.1. Personal Facultativo.** Un médico especialista en Endoscopias que se especificará en cada uno de los protocolos de procedimiento, debiendo estar en posesión de la titulación establecida en la legislación vigente y con una experiencia de 4 años en desarrollo de la actividad correspondiente a la especialidad de que se trate y de la realización 3000 exploraciones mediante esta técnica, con sus informes correspondientes. El Médico endoscopista deberá estar capacitado para la Sedación de pacientes. En caso contrario se deberá contar en la Sala con un Médico Especialista en Anestesia que se encargue de la Sedación de los pacientes.

9.3.2. Personal sanitario no Facultativo

- Un diplomado en enfermería, con la titulación establecida en la legislación vigente y con una experiencia de 6 meses en desarrollo de la actividad correspondiente. Jornada en el centro de 35 horas semanales.
- Un auxiliar de enfermería, con la titulación establecida en la legislación vigente y con una experiencia de 6 meses en desarrollo de la actividad correspondiente. Jornada en el centro de 35 hora semanales.

- 9.3.3. Personal no sanitario.** Un administrativo con la titulación establecida en la legislación vigente. Jornada en el centro de 35 horas semanales.

- 9.3.4. Plan de formación.** Deberá existir un plan de formación protocolizado que garantice 12 horas/año por profesional.

9.4. BLOQUE D. ORGANIZACIÓN EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

9.4.1. Horario del Servicio

- Con carácter general, la realización de los procedimientos será de siete horas diarias en horario de mañana y/o tarde.
- No obstante, en caso de contratación de paquetes de servicios (lista de espera y similares), se ajustará al horario que se pacte con el centro contratante.



- Durante el horario establecido en los dos apartados anteriores se realizarán los procedimientos objeto de servicio a pacientes enviados desde régimen ambulatorio, según determine el centro contratante.

9.4.2. Recepción de la solicitud de realización de la prueba: Para la concertación de exploraciones, el Hospital podrá elegir entre:

- Utilizar un sistema de solicitud electrónica generada desde su sistema de información y enviada en forma de lista de trabajo, a través de Internet u otra conexión equivalente, al centro concertado.
- Cuando se elija el sistema electrónico, el centro concertado estará obligado a adecuar su sistema de recepción de solicitudes, sin coste para el centro contratante, de forma que acepte correctamente las listas de trabajo remitidas por éste.
- Cuando se elija el modo impreso, la recepción de las solicitudes de exploración se realizará mediante la recogida física de las mismas, con periodicidad diaria, por personal de la entidad adjudicataria o servicio de mensajería de ésta dependiente, del lugar o lugares que designe el centro contratante, excepto en el caso en que éste así lo estime conveniente, en el que la solicitud podrá realizarse vía telefónica, adjuntándose, en todo caso, el impreso de solicitud en el momento de la realización de la prueba.

9.4.3. Comunicación de la fecha de realización de la exploración (citación):

- Pacientes en régimen ambulatorio: la entidad adjudicataria realizará la citación, en un plazo no superior a tres días laborables, directamente al paciente o persona responsable del mismo por vía telefónica.
- Pacientes hospitalizados: la entidad adjudicataria la realizará, vía telefónica, fax o escrita, en un plazo no superior a 2 días laborables, a la dependencia o dependencias del centro contratante que éste designe.
- Pacientes urgentes: La entidad adjudicataria la realizará vía telefónica a tiempo real a la dependencia o dependencias del centro contratante que éste determine.
- En el caso de no poder contactar, tras repetidos intentos, con el paciente o con personas que de forma garantizada son próximas a él, la entidad adjudicataria deberá comunicarlo, con la mayor brevedad, al centro contratante, por el procedimiento que éste determine

9.4.4. Realización del procedimiento: Las demoras en la realización de las pruebas, salvo en el caso de que se especifique una fecha concreta posterior en la solicitud, serán: en pacientes urgentes 3 horas, en pacientes hospitalizados 2 días laborables, en pacientes en régimen ambulatorio 10 días laborables.

9.4.5. Historia Clínica. La entidad contratada deberá disponer de una historia para cada paciente, a disposición del centro contratante durante 10 años, con los apartados de: anamnesis, exploración física, datos sobre la prueba y sus resultados, diagnóstico, objetivos, tratamiento y curso



evolutivo. Se deberá cumplir la normativa legal vigente en cuanto a confidencialidad, seguridad y archivo.

9.4.6. Procedimientos normalizados de trabajo. Existirán procedimientos normalizados escritos y específicos de las siguientes actividades:

- Asistencia sanitaria prestada en cada uno de los procesos, exploraciones y técnicas diagnósticas y/o terapéuticas utilizadas tanto por facultativos como por personal sanitario no facultativo.
- Tareas administrativas y de atención al paciente por personal no sanitario.
- Limpieza y mantenimiento de equipos e instalaciones.

9.4.7. Programación. Durante la llamada de citación por parte de la empresa adjudicataria, al paciente se le indicará la fecha y la hora en la que se le realizará el procedimiento, y se le indicará que debe pasar por la consulta de enfermería de su centro de salud o consultorio local, al menos 5 días antes de la fecha de la endoscopia para recibir por escrito, la preparación que debe realizar y el material necesario para hacerlo.

9.4.8. Seguimiento de la asistencia. La fecha y la hora de todas las citaciones, deberá ser informada por correo electrónico al Complejo Asistencial de Segovia, para que éste a su vez, pueda informar a cada Zona Básica de Salud, de los pacientes que acudirán a consultas de enfermería, solicitando la preparación. Igualmente, este listado de citaciones, deberá servir a centro contratante y contratado para el seguimiento de la asistencia de los pacientes derivados. El centro contratado, deberá disponer de un documento donde quede reflejada la asistencia de cada paciente, así como, un protocolo de seguimiento de las ausencias.

9.5. BLOQUE E. REALIZACION DEL PROCEDIMIENTO

9.5.1. Normas Generales. El cumplimiento del contenido de los protocolos que se describen a continuación constituyen requisito mínimo, pudiéndose ampliar y añadir las exploraciones y/o modalidades diagnósticas/terapéuticas que los facultativos especialistas correspondientes, de la entidad contratada estimen convenientes según su leal saber y entender, las normas de buena práctica clínica y la situación del conocimiento científico en cada momento.

Teniendo en cuenta la evolución del conocimiento científico, una vez formalizado el contrato, los protocolos, que se describen a continuación, pueden ser modificados, y añadirse otros de procedimientos nuevos, siempre con los objetivos de conseguir mayor facilidad de realización con menores molestias y un aumento



en su capacidad terapéutica y seguridad para el paciente. Estas modificaciones deberán contar con la aprobación del órgano de contratación. De la misma forma los criterios de inclusión y exclusión, en cada procedimiento, serán relativos y susceptibles de modificación por el órgano de contratación o con su aprobación previa. .

Siempre que las características técnicas del equipamiento lo permitan, y basándose en el conocimiento científico, en cada protocolo específico, de forma general o en un paciente concreto, la entidad contratada modificará, a requerimiento del centro contratante, las características del mismo.

9.5.2. Primera consulta

- Se entiende que los pacientes vienen derivados desde la consulta de Atención Primaria, en donde se les ha explicado la indicación del procedimiento, el objetivo del mismo, se les ha entregado la información del procedimiento y se le ha hecho firmar el consentimiento informado. No obstante, todos los pacientes deberán firmar un consentimiento informado en el centro contratado en donde se hagan constar los derechos y obligaciones del paciente y de la entidad contratada, así como, los datos de referencia de ésta última. Igualmente se informará del mecanismo y soporte de las reclamaciones y sugerencias, debiéndose cumplir, en todo momento, la normativa vigente.
- Se entregará al paciente un documento de recogida de opinión sobre la prestación del servicio, que se recogerá al acabar la prueba.
- Consentimiento informado: Se deberá obtener el Consentimiento, firmado por el paciente o persona legalmente autorizada previa información detallada, oral y escrita en protocolo específico, de las posibles consecuencias y efectos secundarios de la prueba. El facultativo que realiza el procedimiento deberá asegurarse de que éste está indicado y no existen contraindicaciones
- Pauta de la limpieza por vía oral: La pauta de administración de la preparación se le deberá dar por escrito al paciente con claridad y con anticipación suficiente que permita una adecuada limpieza del colon.
- El preparado para la limpieza del colon (Citraflet©) le será entregado al paciente en las Consultas de Atención Primaria desde donde se haya solicitado la Exploración
- Preparación del paciente: se seguirán las recomendaciones de los **Anexos 2 y 3**

9.5.3. Realización de la exploración

- Anestesia/sedación: Se individualizará cada caso, utilizando siempre la opción que produzca los máximos beneficios y el mínimo riesgo para el paciente.
- Para la realización de la Colonoscopia se seguirán las normas y principios establecidos por el conocimiento científico actualizado y las sociedades científicas de la especialidad.
- Si como consecuencia de la realización de la prueba diagnóstica surgen complicaciones (hemorragia o perforaciones) el paciente será derivado al Centro de referencia (GASS). correrán a cargo del adjudicatario los tratamientos derivados de las complicaciones que superen el porcentaje de la literatura científica.



- En el lote de colonoscopias, si la proporción de complicaciones sobrevenidas que se puedan atribuir a la realización de procedimiento (sangrado, perforación, etc) superan lo esperado/descrito en la literatura científica (<0,5%), el centro adjudicatario deberá asumir el coste derivado del manejo integral que estos pacientes requiriesen en el centro contratante.

9.5.4. Anatomía Patológica

- Las muestras de biopsias y polipectomía se recogerán en frascos específicos para recogida de muestras biológicas para Anatomía Patológica con formol tamponado al 10% como fijador.
- Los frascos serán aportados por la empresa adjudicataria.
- Los frascos deberán estar etiquetados con los datos del paciente, y numerados de acuerdo con el orden en que se han recogido las muestras, de forma que se encuentren perfectamente identificados. Los datos mínimos del paciente deben ser nombre completo, fecha de nacimiento, DNI, nº de la seguridad social y número de historia clínica. Los datos deberán de estar presentes tanto en cada uno de los envases como en el informe de endoscopia que hará la doble función de hoja de solicitud de biopsia. También es imprescindible que figure el médico solicitante (al menos en la solicitud).
- Las muestras deberán acompañarse de una copia del informe de la endoscopia. En el informe de la endoscopia se incluirá la descripción exacta de las muestras enviadas en cada recipiente (descripción y localización de la lesión, así como número de muestras o fragmentos enviados) y diagnóstico clínico o diagnóstico diferencial planteado.
- El envío, procesamiento y análisis de las muestras al servicio de Anatomía Patológica serán asumidos por la empresa adjudicataria, en las siguientes 72 horas (máximo) desde su obtención.
- El servicio de Anatomía Patológica que las procese será el propio servicio de Anatomía Patológica de la empresa adjudicataria, en donde el personal técnico del servicio se encargará de su recepción y quien comprobará la adecuación y correspondencia entre las muestras y los informes de endoscopia enviados.
- Los informes de biopsia, una vez finalizados y validados por un patólogo del Servicio de Anatomía Patológica, serán enviados de manera cifrada y electrónica al centro contratante para su carga a la Historia Clínica Electrónica de cada paciente, desde donde podrán ser consultados por los profesionales clínicos responsables del seguimiento de los pacientes. Los informes deben contener datos de identificación del especialista que realiza el informe, Nº de colegiado, especialidad, fecha de exploración y firma y sello del mismo

9.6. BLOQUE F. INFORME DE RESULTADOS

9.6.1. Contenido del Informe

- **Datos de identificación**
 - Datos del paciente: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y número de historia clínica.
 - Datos del facultativo y entidad que deriva al paciente.
 - Motivo de la solicitud del estudio.



- **Datos de realización del procedimiento**

- Información Clínica aportada en el impreso de solicitud.
- Protocolo de realización de la prueba: Protocolo clínico y protocolo de ejecución.
- Incidencias durante la realización de la prueba (si las hubiere).
- Descripción y límites de la/s zona/s anatómica/s explorada/s.
- Descripción morfológica de los hallazgos significativos, relacionados o no con el diagnóstico que figure en el impreso de solicitud. Diagnóstico diferencial y actuaciones recomendadas si fuera necesario.
- Imágenes endoscópicas (fotografías) obtenidas durante la realización del procedimiento, de los hallazgos más relevantes clínicamente.
- Descripción de los hallazgos del estudio histológico y el procedimiento de obtención de la muestra para el mismo en el caso de su realización.
- Juicio Clínico (diagnóstico) basándose en los hallazgos de exploración y en los datos clínicos aportados en el impreso de solicitud.
- Datos de identificación del especialista que realiza el informe, fecha de exploración y firma del mismo.

- **Demora en la emisión y entrega del informe**

- Pacientes en régimen ambulatorios: 3 días laborables tras la realización de la prueba.
- Pacientes hospitalizados y/o urgentes: 1 día laborable tras la realización de la prueba.

9.6.2. Soporte del Informe

- Escrito acompañado de documentación gráfica, en su caso, de la/s exploración/es complementarias realizada/s. En la documentación gráfica deberán figurar los datos de identificación del paciente.
- La empresa adjudicataria deberá transmitir el informe de la Colonoscopia mediante correo electrónico encriptado. Los informes compartirán el mismo tipo de soporte y la misma vía de envío.
- El centro contratante podrá optar alternativamente por un informe escrito, previa autorización del centro contratante, acompañado de documentación gráfica de la/s exploración/es realizada/s. En ese caso, en la documentación gráfica (imágenes), deberán figurar impresos.
- Previa autorización del centro contratante, los informes de resultado y las imágenes se podrán integrar telemáticamente en el Complejo Asistencial de Segovia. La viabilidad de la integración será cumpliendo estrictamente con lo indicado en **Anexo I (PPT)**.

9.6.3. Procedimiento de Entrega

- El envío de imágenes e informes se realizará por sistemas red de transmisión segura, si así lo solicita el centro contratante.
- Los informes escritos así como la documentación gráfica (imágenes), y si lo requiere el Órgano de Contratación el CD o DVD, serán entregados físicamente por el personal de la entidad adjudicataria, o servicio de mensajería de ésta dependiente, en la o las dependencias que el centro contratante designe.



- Copia del informe de resultados deberá permanecer a disposición del centro contratante durante 5 años.

9.6.4. Entrega al paciente de un resumen del informe. Además de lo especificado anteriormente, el paciente debe recibir en el momento de abandonar la instalación donde se realiza la prueba, un informe preliminar con el procedimiento realizado, los principales hallazgos y las recomendaciones a seguir hasta la visita médica para información de resultados, valoración diagnóstica y planificación terapéutica.

9.6.5. Confidencialidad. El licitador tendrá que presentar una memoria descriptiva de las medidas que adoptará para asegurar la confidencialidad e integridad de los datos y de la documentación facilitada. Para la prestación de los servicios descritos en este pliego que impliquen un acceso a los datos de carácter personal, de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el contratista se constituirá como encargado de tratamiento, asumiendo los siguientes compromisos:

- Velará por la confidencialidad y secreto de los datos personales respecto de las cuales el Complejo Asistencial de Segovia tenga la condición de responsable.
- Sólo tratará los datos a los que tenga acceso con el fin de cumplir las funciones encomendadas en el pliego. No aplicará o utilizará los datos con finalidad diferente a la finalidad propia del presente contrato, ni las comunicará a terceros en ningún caso.
- Si el contratista requiere subcontratar con terceros prestaciones accesorias del presente contrato, o tuviera que facilitar a terceros proveedores acceso a los datos personales objeto del presente pliego, necesitará autorización expresa previa del Hospital.
- Dar cumplimiento a las medidas de seguridad de nivel alto contempladas el RD 1720/2007, en concreto, aquellas medidas de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
- Las medidas indicadas serán de obligado cumplimiento, bajo penalidad de rescisión de contrato por parte de Hospital, reservándose, si hace falta, la capacidad de iniciar acciones legales ante el incumplimiento de las mismas por los perjuicios que se pudieran derivar.
- Una vez finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal se conservarán durante los plazos máximos legalmente establecidos y no podrá ser utilizadas con finalidades diferentes a las mencionadas.
- La obligación de confidencialidad se mantendrá vigente por tiempo indefinido con posterioridad a la resolución del presente contrato por cualquier causa.
- El contratista tendrá que comunicar cualquier incidencia que se produzca en relación con los datos objeto de la prestación del servicio. El responsable del fichero se reserva el derecho de pedir información en relación al tratamiento de datos llevado a término por el contratista.



- 9.6.6. Hoja informativa y de reclamaciones.** Se entregará una "hoja informativa" para cada paciente, en la que se harán constar los derechos y obligaciones del paciente y de la entidad contratada. Igualmente se informará del mecanismo y soporte de las reclamaciones y sugerencias. Deberán disponer de hojas de reclamaciones según establece el Decreto 40/2003 de 3 de abril, relativo a las Guías de información al usuario y a los procedimientos de reclamación y sugerencia en el ámbito sanitario.

10. REQUISITOS MINIMOS PARA ESTUDIOS DE SUEÑO (POLISOMNOGRAFIAS) LOTE 7

10.1. BLOQUE A. EQUIPAMIENTO

10.1.1. Normativa:

Será de obligado cumplimiento, en todo momento, toda la reglamentación y normativa legal aplicable vigente tanto a nivel internacional y de la UE, como nacional, autonómica o local, para la ubicación, funcionamiento y seguridad de este tipo de instalaciones (incluyendo criterios internacionales especificados en el real decreto 414/1996 del 1 de Marzo y marca CE) y de todos los equipos utilizados, electromédicos o no, y para todo el material fungible que se precise, debiendo estar todos ellos validados y en correcto estado de funcionamiento.

Se deberá disponer de las correspondientes licencias y/o autorizaciones emitidas por las pertinentes administraciones u organismos.

10.1.2. Polisomnógrafo.

El equipo de registro para la realización de la polisomnografía tendrá que permitir el siguiente montaje mínimo:

- 18 EEG (que permita un montaje completo)
- 2 EOG
- 3 EMG (1 mento/submentoniano, y 2 tibiales anteriores)
- SaO₂
- Señal de ronquido
- Sensor de posición corporal
- Señal de presión/flujo aéreo oro-nasal
- Esfuerzo ventilatorio
- ECG
- Video monitorización

10.1.3. Otro equipamiento.

Se deberá disponer de:

- Farmacopea (oxígeno, bicarbonato, adrenalina, atropina, lidocaína, dopamina, dobutamina y aleudrina, etc) y equipamiento completo de reanimación cardiopulmonar (carro de RCP) incluyendo desfibrilador miocárdico (laringoscopia, tubos orotraqueales, vías venosas centrales y pulmonares, bolsa de resucitación unidireccional, etc).



- Oxigenoterapia, sistemas de vacío y aire comprimido, con mascarilla y gafas nasales adecuadas al paciente.
- Refrigerador convencional con registro gráfico de temperatura, para almacenamiento de material (fármacos, etc)
- Para el adecuado control de la apnea de sueño se plantea la realización de titulación de la presión mínima efectiva de la CPAP para corregir los eventos respiratorios. El método recomendado es la titulación manual mediante PSG convencional, siguiendo el protocolo propuesto por la AASM. Aparte del montaje esencial de neumología dentro de un laboratorio de sueño se requiere personal entrenado para la realización de una adecuada titulación. Se deberá disponer de un dispositivo CPAP con tubuladura y diferentes interfaces; así como la posibilidad de registro de los canales de presión, flujo y fuga que aporta el dispositivo CPAP para una correcta titulación. El programa empleado deberá calcular el IAH residual para una correcta valoración final.

10.2. BLOQUE B. LOCALES E INSTALACIONES

Será de obligado cumplimiento la normativa legal local, autonómica y estatal vigentes, para la construcción y puesta en marcha de este tipo de instalaciones, así como toda la normativa de aplicación general.

10.2.1. Ausencia de barreras arquitectónicas. No existirán barreras arquitectónicas en acceso a:

- Edificio: Permitirá acceso de vehículos de transporte sanitario.
- Instalaciones y Sala de exploración: Permitirá acceso y desplazamiento de pacientes en camilla y sillas de ruedas.

10.2.2. Locales y dependencias

- **Zona de recepción /admisión de pacientes y acompañantes.**
 - Permitirá la realización de las funciones de atención e información al usuario, planificación de pruebas., control de asistencia de los pacientes, procesos administrativos del servicio y atención telefónica. Posibilidad de informar a personas tanto con movilidad normal como reducida (silla de ruedas o camilla).
 - Ha de estar emplazada a la entrada del centro, en lugar visible y estratégico para que pueda ser vista por cualquier persona que entre.
- **Secretaría y área administrativa.** Existirá el equipamiento necesario para:
 - Realización y envío de informes de resultados.
 - Archivo de informes en soporte informático.
 - Archivo de informes e historia clínica en soporte convencional.
- **Sala de espera.** Superficie de 3m² para pacientes y acompañantes, con un ratio mínimo de 1,25 m² por persona, permitiendo la entrada y estacionamiento de dos sillas de ruedas



- **Sala de Estudio.**

- La habitación dispondrá de dos camas. Una para el paciente y otra, cuando sea menor de edad, para su acompañante. Sólo se podrá utilizar cada habitación para hacer un único estudio del sueño, no estando permitido el uso de una habitación doble para realizar dos estudios a la vez.
- La habitación tendrá una superficie mínima de 12 m² que garantice la intimidad del paciente, con baño individual dotado de WC, ducha y lavabo.
- Se debe poder atenuar la luz y el sonido y poder controlar la temperatura y la ventilación de las habitaciones.
- Se debe disponer de una habitación separada para los equipos de monitorización y para el personal técnico y/o de enfermería. Debe ser suficientemente amplia y debe poder permitir trabajar en unas correctas condiciones, sin molestias. No es aceptable que se realice un registro polisomnográfico al lado de la cama del paciente.
- Deberá estar instalado un sistema de comunicación bidireccional para permitir que el paciente y el técnico se puedan comunicar entre sí y para que pueda efectuarse la correcta calibración de las señales biológicas.

- **Archivo.** Espacio destinado para archivo de historias clínicas. Deberá garantizar la privacidad y seguridad de los documentos.

- **Almacén.** Zona de almacén de material y medicamentos.

10.2.3. Aspectos generales. Deberá disponer de instalación de un sistema de aire acondicionado y calefacción.

10.2.4. Servicio de limpieza y mantenimiento. La entidad contratada deberá disponer de los medios necesarios, propios o contratados, para garantizar la limpieza y mantenimiento de todas las instalaciones.

10.3. BLOQUE C. RECURSOS HUMANOS

10.3.1. Personal Facultativo. Un facultativo especialista con capacitación específica en trastornos del sueño, que evaluará el informe clínico recibido, determinará las características del estudio a realizar y elaborará el informe resultante de la polisomnografía.

10.3.2. Personal sanitario no facultativo y/o técnicos especialistas en polisomnografía. Un técnico, con la titulación establecida en la legislación vigente y con una experiencia mínima de 6 meses en el desarrollo de la actividad correspondiente a la especialidad de que se trate. Llevará a cabo la colocación del material necesario para la realización del registro polisomnográfico y supervisará de forma ininterrumpida la adquisición del mismo, así como el estado del paciente. Cuando los pacientes objeto del estudio solicitado sean pediátricos de edad igual o menor a 6 años, será objeto de negociación



y valoración, que la empresa oferte la intervención dos técnicos en su realización.

10.3.3. Personal no sanitario. Un administrativo con la titulación establecida en la legislación vigente, que se encargará de los trámites administrativos inherentes al proceso.

10.4. BLOQUE D. ORGANIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

10.4.1. Comunicación de la fecha de realización del procedimiento (citación):

- Desde la derivación del paciente por parte del Servicio de Admisión del Complejo Asistencial de Segovia, transcurrirá un plazo no superior a 3 (tres) días laborables, para que la adjudicataria contacte directamente con el paciente o persona responsable del mismo. En el caso de no poder contactar, tras repetidos intentos, con el paciente o con personas garantizadamente próximas a él, la entidad adjudicataria deberá comunicarlo, a la mayor brevedad, al Complejo Asistencial de Segovia, por el procedimiento que éste determine.
- El Complejo Asistencial de Segovia facilitará los siguientes datos del paciente a través de correo electrónico:
 - Datos del paciente: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y número de identificación del paciente, y teléfono de contacto.
 - Informe clínico del paciente en el que conste: datos del profesional petionario, motivo de la solicitud del estudio y tipo de estudio solicitado

10.4.2. Demoras. Las demoras en el inicio del procedimiento (contando a partir del momento de solicitud), salvo en el caso de que se especifique una fecha concreta posterior en el impreso de solicitud, serán de 8 (ocho) días laborables. Será objeto de negociación y valoración la reducción en el plazo establecido para el inicio del procedimiento.

10.4.3. Procedimientos normalizados de trabajo

- El paciente recibirá por parte de la adjudicataria las instrucciones pertinentes previas a la realización de la prueba.
- En caso de producirse situaciones clínicas sobrevenidas que requieran la intervención de personal médico, se contará con un sistema de aviso inmediato y del circuito pertinente para su resolución en tiempo y forma.
- Durante la totalidad de la prueba se encontrará presente el personal técnico y/o sanitario encargado de su supervisión.

10.4.4. Historia Clínica. La adjudicataria deberá disponer de una historia para cada paciente, a disposición del centro contratante durante un mínimo de 10 años, con los apartados de: anamnesis, exploración funcional, diagnóstico, objetivos, tratamiento y curso evolutivo. Se deberá cumplir



la normativa legal vigente en cuanto a confidencialidad, seguridad y archivo.

10.4.5. Documentación a entregar al paciente

- **Hoja informativa.** En consulta para la realización del procedimiento se entregará una "hoja informativa" a cada paciente. En ella se harán constar los derechos y obligaciones del paciente y de la entidad contratada, así como, los datos de referencia de ésta última. Igualmente se informará del mecanismo y soporte de las reclamaciones y sugerencias debiéndose cumplir, en todo momento, la normativa vigente.
- **Cuestionario de opinión;** se entregará al paciente un documento de recogida de opinión sobre la prestación del servicio, que se recogerá al finalizar la prueba. En este documento, deberán constar:
 - Actitud y trato de los profesionales
 - Valoración de la limpieza del servicio.
 - Valoración de la información recibida.
 - Valoración subjetiva del resultado de procedimiento.

10.4.6. Entrega de resultados e informes. Se establece un límite máximo entre 7 (siete) días laborables desde la fecha de realización de la polisomnografía para el envío del informe con los resultados de la prueba practicada. Será objeto de negociación y valoración la reducción en el plazo establecido para la entrega de los resultados.

10.4.7. Seguridad de la información y protección de datos

- El Prestador del servicio (en adelante, el Prestador), deberá cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, y deberá conocer y cumplir la Política de Seguridad de la Información y Protección de datos vigente en la Gerencia Regional de Salud (en adelante, GRS), así como las normas y controles de seguridad que se han de aplicar en relación a los servicios contratados con objeto de garantizar la confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos personales y de la información; todo ello de acuerdo a las instrucciones técnicas incluidas en el presente Pliego.
- Además, la GRS podrá exigir al Prestador la aplicación de medidas de seguridad adicionales cuando los requisitos de seguridad aplicables al servicio así lo requieran.
- Para una correcta gestión del servicio o servicios objeto de contratación, así como de la seguridad de los datos personales y sistemas implicados, el Prestador deberá proveer a la GRS de toda la información necesaria que permita evidenciar una adecuada diligencia en su relación con la GRS, para la correcta gestión del servicio objeto de contratación.
- Asimismo, el Prestador ha de ser capaz de demostrar que cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, y que son exigidas por la legislación aplicable en materia de seguridad de la información y protección de datos personales; las cuales deberán de proveerse a la GRS, en caso de ser requeridas.
- Por su parte, la GRS tratará los datos de carácter personal que se recaban como consecuencia de la relación contractual, con la finalidad de tramitar los



expedientes de contratación y la formalización, desarrollo y ejecución del contrato. Dichos datos podrán ser comunicados a las distintas entidades financieras, a la Agencia de Administración Tributaria, sí como a los diferentes órganos de la Junta de Castilla y León; y podrán ser incluidos en la Plataforma de Contratación de la Comunidad de Castilla y León.

- Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que han sido recabados y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación. Se podrán ejercitar los derechos reconocidos en la normativa de protección de datos en la dirección de correo electrónico dpd@saludcastillayleon.es; pudiendo, en cualquier caso, interponerse reclamación ante la AEPD (www.aepd.es).

10.4.8. Descripción del servicio prestado e información a la que se necesita acceder. En su oferta, el Prestador deberá aportar la descripción del servicio y la modalidad de prestación, con indicación del alcance y funciones operativas o de control. En todo caso, se deberá indicar en que modalidad se va a desplegar el servicio (de manera física, en modo local, on-premise, en la nube, externalizado, mediante subcontratación, etc.) Asimismo, se deberán especificar los tratamientos de datos personales que se van a realizar, sus finalidades y el alcance de los mismos.

10.4.9. Información sobre la arquitectura de seguridad. Es requisito obligatorio que el Prestador aporte la información necesaria sobre el sistema que soporta el servicio, respecto a la arquitectura de seguridad, con el objeto de facilitar a la GRS el cumplimiento de sus obligaciones, tales como la realización del análisis de riesgos o el subsiguiente plan de tratamiento de riesgos. Asimismo, deberá aportar los diagramas de red, esquemas de elementos físicos, esquemas de interconexión y esquemas lógicos de sistemas que muestren a la GRS la infraestructura física y lógica de la que forma parte el servicio objeto de contratación.

10.4.10. Servicios en la nube. Portabilidad de la información. En caso de que el servicio se contrate a prestadores de servicios con solución de servicios en la nube El Prestador deberá de ser capaz demostrar que cumple con las medidas de seguridad exigidas por el ENS y deberá estar certificado bajo una metodología de certificación reconocida por el CCN. Asimismo, el Prestador deberá demostrar que cuenta con mecanismos que garanticen la portabilidad de la información, ante el cese o baja del servicio suministrado por parte del Prestador de servicio y, deberá certificar que, al causar baja el servicio suministrado, los datos almacenados han sido eliminados de manera segura una vez finalizado el proceso de portabilidad.

10.4.11. Ubicación de la información. En su oferta, el Prestador del servicio deberá detallar si la información se va a tratar en sistemas e



instalaciones suyas propias o de la GRS. En caso de que el tratamiento se vaya a realizar en instalaciones propias, el Prestador tendrá que presentar una declaración en la que ponga de manifiesto la ubicación física/geográfica de sus sistemas de información y repositorio de información implicados en la prestación del servicio, y las medidas de seguridad física asociadas, de cumplimiento con la legislación aplicable en materia de seguridad de la información y protección de datos. Asimismo, el Prestador quedará obligado a comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada relacionada con la ubicación de sus servidores.

10.4.12. Cadena de subcontratación. La subcontratación no está permitida, salvo autorización expresa y por escrito de la GRS, previa comunicación del Prestador del servicio con una antelación de 30 días; en cuyo caso, el Prestador deberá disponer y aportar la documentación que detalle claramente los elementos que forman parte de la cadena de subcontratación, así como las implicaciones derivadas de cualquier cambio o modificación que pueda sufrir algún eslabón de dicha cadena. La GRS se reserva el derecho de requerir al Prestador la documentación que evidencie las medidas de seguridad y de vigilancia utilizadas por los subcontratistas.

10.4.13. Medidas de seguridad implementadas. La GRS podrá requerir al Prestador del Servicio, las medidas de seguridad de la información que tiene implementadas para prestar el servicio. De esta forma, la GRS como destinataria del servicio, podrá dar conformidad a sus propios requisitos del ENS y PSIPD, así como conocer si existen medidas de seguridad adicionales o complementarias a las exigidas por la categoría de su/s sistema/s de información.

10.4.14. Seguridad en las instalaciones del Prestador. En aquellas instalaciones donde se almacene o procese información de la GRS, el Prestador deberá implementar medidas de seguridad física, ambiental y de control de acceso, y todo su personal deberá participar activamente en la implantación y cumplimiento de estas medidas.

10.4.15. Protección del equipamiento informático. Acceso remoto a la información de la GRS En todo aquel equipamiento informático propiedad del Prestador en el cual se almacene, procese o desde el que se acceda a información de la GRS, el Prestador deberá aplicar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de dicha información. Entre otras, el Prestador deberá aplicar las siguientes medidas de seguridad:

- Protección contra código malicioso: todos los equipos deberán contar con programas antivirus y de protección ante software malicioso (malware) actualizados de forma automática y permanente.
- Control de acceso: todos los equipos deberán disponer de medidas que aseguren el acceso sólo por parte del personal autorizado.
- Bloqueo de terminales: no se deberán dejar los terminales desatendidos sin antes haber bloqueado la sesión de usuario con el fin de evitar accesos no



autorizados. El bloqueo automático tras un periodo de inactividad también debe estar activado.

- Actualización de sistemas: todo el equipamiento informático deberá estar al día con las últimas actualizaciones y parches de seguridad disponibles.
- Salvaguarda de la información: se han de implementar mecanismos de copia de seguridad y recuperación en aquella información de la GRS.
- Privilegios: los usuarios no deben poder deshabilitar o desinstalar las protecciones de seguridad implantadas en los equipos.
- La GRS se reserva el derecho de exigir la implantación de las medidas de seguridad adicionales que considere oportunas, en el equipamiento informático del Prestador

10.4.16. Transmisión de información por parte del Prestador a otras

entidades. El Prestador no podrá transmitir, enviar, compartir o poner a disposición de otras entidades información propiedad de la GRS, a no ser que de manera previa haya sido expresamente autorizado para hacerlo, independientemente del medio o formato de la información y de su contenido. En el caso de existir dicha autorización, se podrá transmitir única y exclusivamente la información estrictamente necesaria para que el Prestador pueda llevar a cabo su cometido. Las obligaciones del Prestador en materia de seguridad de la información se deberán hacer extensivas al receptor de la información. El Prestador será responsable del uso y la protección de la información de la GRS que le haya sido proporcionada, así como de los perjuicios ocasionados a la GRS en los casos en los que la seguridad de la información o de los datos personales hubieran sido comprometidas.

10.4.17. Cumplimiento del personal con las medidas de seguridad de la

GRS. El Prestador deberá concienciar y formar a su personal en materia de seguridad de la información y de protección de datos, y en particular sobre aquellos aspectos de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos de la GRS vigente y su marco normativo de seguridad, que sean de aplicación en base a la naturaleza del servicio prestado.

- Los trabajadores del Prestador por su parte deben tener siempre presentes durante el desempeño de sus funciones los principios de la ética, la profesionalidad, la confidencialidad y la responsabilidad.
- De forma general, todo el personal del Prestador que acceda a la información de la GRS deberá cumplir con las siguientes normas:
 - Acceder exclusivamente a los sistemas de información mediante el acceso y los medios autorizados.
 - Proteger la confidencialidad de la información de toda revelación no autorizada.
 - Proteger la integridad de la información de la GRS a la que tenga acceso en el ámbito de la prestación del servicio.
 - Proteger la información, los datos personales y los sistemas de información de cualquier alteración no autorizada.



- Todas las personas empleadas por el Prestador deben hacerse responsables de la custodia personal de las credenciales que tienen asignadas para el acceso a los recursos de los sistemas de información de la GRS. Estas credenciales nunca podrán ser facilitadas a terceras personas, sean o no empleados del Prestador, y los propietarios de las mismas deberán ser únicos responsables del uso que se haga de ellas. Además, el Prestador deberá poner en marcha medidas de control para garantizar la supervisión de las actuaciones para sus trabajadores.

10.4.18. Incidentes de seguridad. El Prestador tiene la obligación de comunicar a la GRS cualquier incidente acaecido que afecte a la seguridad de los datos personales, de la organización o a sus sistemas de información, en cuanto tenga conocimiento de ello, sin dilaciones y a la mayor brevedad posible, dentro de un plazo no superior a 24 horas. De igual forma, para la resolución de un incidente de seguridad que ocurra en la GRS, se podrá pedir la colaboración del Prestador, al objeto de calibrar el impacto del incidente y la adopción de las medidas necesarias de contención, mitigación, respuesta y recuperación. En cualquier caso, el Prestador y personal a su cargo o colaboradores, están obligados a la confidencialidad y deber de secreto respecto de la información a la que puedan tener acceso y conocer, como consecuencia del incidente de seguridad.

10.4.19. Seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio. El Prestador del servicio deberá facilitar herramientas de monitorización o informes periódicos de modo que permita a la GRS realizar el seguimiento y gestión del cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos contractualmente, que detallan lo que se considera calidad mínima del servicio prestado, las consecuencias de su incumplimiento y responsabilidad de las partes. El Prestador del servicio ha de actuar proactivamente en este ámbito, aportando los datos con total transparencia y gestionando los incumplimientos diligentemente.

10.4.20. Continuidad del servicio. Con el fin de que la GRS pueda garantizar la continuidad de los servicios prestados, se requerirá que el Prestador le facilite la información necesaria para establecer un plan de continuidad y las responsabilidades establecidas. El Prestador deberá colaborar con la GRS para la coordinación de actividades en caso de incidentes y desastres y deberá definir e implementar medidas y estrategias que garanticen la continuidad de los servicios prestados a la GRS en caso de contingencia. Asimismo, si la naturaleza del servicio prestado lo requiere, el Prestador deberá establecer medios alternativos, planes de recuperación de los sistemas que sirvan para la prestación de los servicios a la GRS, en el caso que los medios habituales estos sean comprometidos por pérdida, alteración o interrupción. La GRS y el Prestador establecerán un tiempo máximo para que los medios alternativos entren en funcionamiento. Los medios alternativos estarán sometidos a las mismas garantías de seguridad que los originales. La GRS se reserva el derecho de exigir al Prestador



medidas de continuidad adicionales, cuando los requisitos de seguridad de los servicios prestados así lo requieran.

10.4.21. Revisión del estado de la seguridad y mejora continua. Durante la prestación del servicio y sin que ello implique un coste adicional para la GRS, el Prestador está obligado a reevaluar y actualizar las medidas de seguridad implantadas, entre las que se encuentran las actualizaciones y mantenimiento del software, de los sistemas operativos, así como de los parches de seguridad, entre otros, con el fin de adecuar su eficacia a la constante evolución de los riesgos y sistemas de protección, llegando incluso si fuese necesario, a un replanteamiento de la seguridad. El Prestador deberá disponer de un sistema de gestión de la capacidad con mejora continua, y evaluación de riesgos continua y dinámica, que proporcione, de forma periódica, información relacionada con el sistema que soporta los servicios, como por ejemplo capacidad, dimensionamiento y rendimiento del sistema.

10.4.22. Auditorias y controles de seguridad. El Prestador del servicio debe proporcionar los mecanismos y funcionalidades que permitan a la GRS conocer y analizar los controles de seguridad llevados a cabo por parte del Prestador, tales como auditorías e inspecciones; permitiendo y colaborando activamente en la realización y desarrollo de las mismas. La GRS podrá exigir al Prestador cualquier evidencia de cumplimiento con la legislación aplicable, de acuerdo a lo marcado en los acuerdos firmados por ambas partes, así como con los requisitos de seguridad impuestos por parte de la GRS. Para ello, la GRS se reserva el derecho de ejercitar las siguientes acciones:

- Revisar o auditar los mecanismos de salvaguarda de la seguridad de la información que tenga implementados el Prestador y que estén relacionados o implicados con los sistemas utilizados en la prestación del servicio contratado.
- Revisar o auditar el cumplimiento por parte del Prestador con la legislación aplicable de acuerdo a lo dispuesto por los contratos firmados por ambas partes.
- Requerir al Prestador los documentos derivados de los procesos de auditoría llevados a cabo por este, así como cualquier otra evidencia sobre el cumplimiento con el marco legal aplicable y con los requisitos impuestos por el presente encargo.
- Solicitar la implementación de cualquier mecanismo organizativo, técnico o jurídico que considere adecuado para garantizar la seguridad de la información y protección de datos.

10.4.23. Finalización del contrato y devolución de activos. En el momento de la finalización del contrato, el Prestador del servicio deberá devolver a la GRS todos los activos de los que haya dispuesto para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, ya sean software, documentación corporativa, equipos y/o recursos materiales. Asimismo, si el personal del Prestador dispone de permisos de acceso a instalaciones o sistemas, estos deben ser devueltos o comunicados para su anulación respondiendo de su uso una vez finalizados los servicios.



- El Prestador del servicio deberá entregar a la GRS toda la información y documentación resultante de los trabajos objeto de la prestación, viniendo obligado, además, a no mantener documentación o almacenar información en locales o equipos ajenos o no autorizados por la GRS, durante o una vez finalizado el plazo contractual, más allá de aquella que sea necesaria para la ejecución del contrato o para el cumplimiento de los periodos de garantía y mantenimiento por parte de dicho Prestador.
- En los casos en que esto sea necesario, deberán garantizarse niveles de seguridad acordes con la naturaleza de la información almacenada y con la Política de Seguridad de la Información y Protección de Datos vigente en la GRS.
- La GRS se reserva el derecho de poder exigir al Prestador, certificaciones de destrucción segura de documentos o eliminación de información de los equipos empleados para la realización de los servicios objeto del contrato, y, podrá realizar revisiones de las instalaciones y procedimientos empleados por el Prestador.
- Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente, el incumplimiento de estos compromisos y las consecuencias derivadas de ello serán responsabilidad exclusiva del Prestador, que responderá frente a la GRS de los daños y perjuicios que pudieran generarse.

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SERVICIO DE EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ULTRASONIDOS. LOTE 8

Las características técnicas y sanitarias que deberán poseer los equipos y los servicios ofertados, así como la dotación de material y personal con que deberán contar, se atenderán a los requisitos generales establecidos por Sacyl, para este tipo de instalaciones.

11.1. INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD Y CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, a través de la Dirección General de Salud Digital, ha impulsado la estandarización e interoperabilidad de los sistemas informáticos y tele-comunicaciones de los Complejos Asistenciales y Hospitales de Castilla y León, vinculando por tanto la aplicación de dichos estándares, al Complejo Asistencial de Segovia.

11.2. REQUISITOS LEGALES

Para llevar a cabo el objeto de este contrato, susceptibles de gestionar información de pacientes, así como del software asociado a los mismos, deberán cumplir



estrictamente la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, e integrarse con el sistema de identificación única del paciente y con el directorio de usuarios, perfiles corporativos y sistemas de seguridad y autenticación del personal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, de la que depende el Complejo Asistencial de Segovia. También deberán adecuarse a los requisitos del Esquema Nacional de seguridad de acuerdo con el Real Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

11.3. REQUISITOS DE INTEGRACIÓN

Todas las aplicaciones informáticas actualmente utilizadas y las que se deban implantar en el Complejo Asistencial de Segovia, deberán cumplir y utilizar los estándares de integración basados en HL7, CDA, perfiles IHE, DICOM 3.0, etc, y en especial los publicados por Sacyl <https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/estandaresint>, para garantizar la inter operatividad de los mismos, de forma completa, dentro del Complejo Asistencial de Segovia y entre el resto de los centros sanitarios de la propia Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. La información que generen los equipos objeto del contrato o el software asociado a los mismos, deberá poder ser integrada, siguiendo estos estándares, en los sistemas de Historia Clínica Electrónica Corporativa de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, y con los sistemas departamentales que se requiera (Gestión de Pacientes, Cuidados de Enfermería, Imagen Médica, Laboratorios, UCI, RIS/PACS, anillo RX, etc.) según condiciones generales respecto al equipamiento TIC de la Dirección General de Salud Digital que posibiliten el cumplimiento de lo establecido por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

La entrega de informes de resultados objeto de este contrato y susceptibles de integración el sistema de información del Hospital, deberán disponer de la conectividad adecuada (Continua Helth Alliance, o normas ISO IEEEEX73) para su integración con los sistemas de información departamentales del Hospital. Incluirán el software, las licencias de uso necesarias, así como su Instalación integrada según los estándares de integración e interoperabilidad de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para su uso completo y adecuado en el Complejo Asistencial de Segovia. Si el software requiriese de licencias de terceros (Microsoft Windows Server o SQL Server), estas deberán ser aportadas por el adjudicatario.

Los sistemas de información del adjudicatario deberán estar preparados para poder recibir y comunicar información, según los estándares internacionales de integración de información médica. En concreto los publicados en las guías de integración de Sacyl disponibles en: <https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/estandaresint>. Cualquier



integración deberá ser probada y validada por los Técnicos del Cluster de Integración de Sacyl, antes de su puesta en producción (ver Anexo I)

11.3.1. Gestión de usuarios

Los accesos a los sistemas informáticos que se instalen deberán estar protegidos por credenciales de acceso (usuario / contraseña).

11.3.2. Almacenamiento de datos y copia de seguridad

Las aplicaciones deberán indicar una previsión de almacenamiento de los datos que utilizará, incluyendo una planificación de crecimiento a 5 años. Cuando el volumen de datos sea superior a 50 GB, se requerirá el uso de un sistema de almacenamiento en dos niveles, teniendo en cuenta que el segundo nivel será una unidad una unidad de almacenamiento en red (protocolos SMB o NFS). También se deberá especificar una planificación de copias de seguridad, indicando qué datos se deberán respaldar y qué frecuencia. Si las aplicaciones no están soportadas por los sistemas de backups de la Gerencia Regional, el proveedor deberá ofrecer un sistema de backups que responda a la planificación dada, incluyendo el hardware, software, licencias y consumibles que sean necesario a tal efecto.

11.3.3. Almacenamiento de imágenes diagnósticas

Las aplicaciones que generen imágenes diagnósticas deberán utilizar el estándar DICOM 3.0 y almacenarlas en los sistemas de almacenamiento de imagen pertinentes (PACS) corporativos:

- En el caso de imágenes/objetos DICOM radiológicas, se podrá utilizar el PACS corporativo (IRE).
- En el caso de imágenes/objetos DICOM cardiológicas, se podrá utilizar el PACS corporativo de cardiología (Xcelera/IntelliSpace Cardiovascular)
- En el caso de imágenes/objetos DICOM no radiológicos, el adjudicatario deberá proveer de un sistema PACS apropiado a sus necesidades

11.3.4. Actualización y calidad de los datos

Cuando un sistema sustituya a otro anterior, bien por cambio de proveedor o por actualización del sistema, deberá ser capaz de almacenar y operar con los datos del sistema al que sustituya de forma que se garantice que la información anterior sigue quedando operativa, al menos como datos de lectura. El proceso de migración de datos deberá garantizar la calidad de los mismos utilizando para ello servicios proporcionados por los Servicios Centrales de la Gerencia Regional (proyecto EMPI), de forma que cada paciente quede perfecta y unívocamente



identificado en toda la región. La gestión de datos del paciente, durante el período de operación de los sistemas, deberá contar siempre con un identificador de historia clínica del hospital, CIPA (identificador regional) y los identificadores a nivel nacional que existan, garantizando, en todo caso, la integridad ante cambios de estos identificadores y, en su caso, de los datos demográficos de los pacientes

11.3.5. Hardware de comunicaciones

En el caso de que los sistemas objeto de este contrato requieran la instalación de una infraestructura de red propia deberán ser los encargados de la instalación y su correcta interoperación con la infraestructura de red del hospital aportando dos sistemas Firewall físicos, uno de ellos administrado por el Servicio de Informática (quien indicará marca y modelo) y otro administrado por la empresa.

11.3.6. Soporte

La empresa adjudicataria se adscribirá a los servicios de comunicación proporcionados por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para llevar a cabo el soporte correctivo y preventivo que especifiquen su SLA. Deberá garantizar la confidencialidad de las comunicaciones y de las credenciales utilizadas para acceder a los distintos subsistemas.

11.3.7. Actualizaciones

Las actualizaciones no se realizarán de manera automática, cada vez que exista una actualización, se deberá comunicar con al menos 15 días de antelación al Servicio de Informática y al Servicio concreto correspondiente; dicha comunicación contendrá, entre otros, la necesidad de la nueva versión, una planificación detallada de todos los pasos posibles y un plan de contingencias en caso de posibles errores.

11.3.8. Hardware informático

Los servidores y equipos de comunicaciones asociados a estos aparatos y equipos médico-asistenciales deberán residir exclusivamente en las dependencias del centro de proceso de datos asignado al Complejo Asistencial de Segovia, o en los armarios de comunicaciones horizontales. No se admitirán sistemas departamentales al margen de la protección del centro de proceso de datos para servidores, o de los armarios de comunicaciones para equipamiento de comunicaciones.

Todo el equipamiento que requiera cualquier tipo de comunicación, así como el equipamiento de comunicaciones estándar asociado al mismo, deberá utilizar y comunicarse a través de la infraestructura de transporte de señal de datos existente. Cualquier propuesta de modificación de nueva instalación al respecto, deberá ser previamente aprobada por la Dirección General de Salud Digital de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, siendo proporcionada por el



adjudicatario sin cargo adicional. Si el sistema necesitase de un servidor, estos se deberán presupuestar aparte, así como cualquier sistema necesario para su funcionamiento completo: servidor, NAS, baccup, sistemas operativos, bases de datos, etc.

El hardware será de marca, no se aceptarán máquinas clónicas Si es posible virtualizar los sistemas servidores, será necesario que remitan las especificaciones técnicas que requiere el sistema para su completo funcionamiento. Deberá soportar una planificación de crecimiento a 5 años (CPU, espacio de almacenamiento, backup, etc). Estos sistemas deberán especificar el periodo de garantía y el tipo de servicio técnico. En este caso deberá contemplar el tiempo de respuesta del proveedor (Horas, días y tiempo de respuesta máximo). Se valorará positivamente la posibilidad de virtualización de los sistemas permitiendo sustituir la plataforma física por otros sistemas informáticos indicados por el Complejo Asistencial de Segovia

11.4. PROPIEDAD, PROTECCIÓN DE DATOS, SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

- Todos los informes, estudios y documentos elaborados durante la implantación, puesta en marcha y funcionamiento del objeto de este contrato, serán propiedad de la Gerencia Regional de Salud. El adjudicatario renuncia expresamente a cualquier derecho que pueda corresponderle, sin la autorización expresa de los responsables de la Gerencia Regional de Salud, previa petición del adjudicatario debidamente motivada. La documentación quedará en propiedad exclusiva de la Gerencia Regional de Salud, sin que el adjudicatario pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de la Gerencia Regional de Salud.

Toda la documentación que se genere como consecuencia de la instalación y configuración del equipamiento objeto de este pliego, deberán entregarse en soporte informático, en los formatos especificados, o los formatos que la GASS indique en su momento para cualquier otro tipo de fichero. Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de protección jurídica de los programas de sistemas de información, el adjudicatario acepta expresamente que los derechos de explotación de las aplicaciones informáticas, de los programas desarrollados o documentación al amparo del presente contrato corresponden únicamente a la Gerencia Regional de Salud, con exclusividad y a todos los efectos.

- De acuerdo con el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas



en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, artículos 32, 33 y 34 del citado reglamento. En concreto lo estipulado en el artículo 33 que textualmente señala lo siguiente: "Que teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, (...) el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo). Y según lo contemplado en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en vigor desde el 7 de diciembre de 2018.

- En consideración al tipo de información procesada, el adjudicatario está obligado a mantener la más absoluta confidencialidad sobre todos aquellos datos y documentos a que tengan acceso con motivo de esta adjudicación. A efectos de la prestación de servicios por parte del adjudicatario de la GASS, el primero tendrá la condición de encargado del tratamiento y se sujetará al deber de confidencialidad y seguridad de los datos personales a los que tenga acceso conforme a lo previsto en la normativa que resulte aplicable. El adjudicatario no podrá comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera para su conservación, debiendo destruir los datos personales a los que haya tenido acceso, así como los resultados derivados de su tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en los que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento, salvo que la Administración requiera que le sean devueltos.
- El adjudicatario deberá aceptar, como parte esencial del contrato, el contrato adicional de encargado del tratamiento de datos que le facilitará la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, y como encargado del tratamiento de datos notificará sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, y a través de correo electrónico y comunicación telefónica al responsable del tratamiento de datos (Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, dirección de correo electrónico: gerente.gasse@saludcastillayleon.es), y al Delegado de Protección de Datos de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, a través de la dirección electrónica dpd@saludcastillayleon.es, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia, así como notificará y asumirá la responsabilidad de cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener como consecuencia la puesta en conocimiento de terceros de información confidencial obtenida durante la ejecución del contrato.



- Así mismo, a la finalización del contrato el adjudicatario quedará obligado a la entrega a la Administración, o destrucción en caso de que así se establezca en el contrato, de cualquier información obtenida o generada como consecuencia de la prestación del objeto del presente pliego.
- El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en el vigente RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal; Reglamento en cuya Disposición Adicional Única se establece que todos los productos de software destinados al tratamiento automatizado de datos personales, deberán incluir en su descripción técnica el nivel de seguridad, básico, medio o alto, que permitan alcanzar de acuerdo con lo establecido en el título VIII de este reglamento; y, en consecuencia, deberán cumplir el nivel de seguridad en él exigido.

11.5. OTRAS CONSIDERACIONES

La empresa adjudicataria se compromete a adoptar y tener en vigor todas las medidas precisas para garantizar la seguridad de los pacientes y personal, así como la calidad de los servicios que preste, en este sentido la empresa adjudicataria se compromete a:

- Garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores, mediante el cumplimiento de las normas de salud laboral, seguridad contra incendios, tratamiento y evacuación de recursos y en general la adopción de todas aquellas medidas que sobre estas materias vengan establecidas por las normas de carácter estatal y autonómico que sean de aplicación, por lo que deberán presentar una memoria descriptiva de las instalaciones.
- Dispondrá de hojas de reclamaciones numeradas. En caso de reclamaciones que hagan referencia a la organización de la prestación de este servicio, se darán a conocer a la GASS.
- Las Normas de manejo de la información clínica por parte de la entidad adjudicataria se adecuarán a la normativa (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de Información y documentación clínica).
- Tendrá suscrito un Seguro de Responsabilidad Civil, para las acciones u omisiones de naturaleza sanitaria o extra sanitaria del centro, empresa o profesionales que presten servicios en el mismo, cualquiera que sea el régimen de vinculación, con cobertura no inferior a 300.000 euros por víctima y siniestro, que cubra los posibles daños o perjuicios que puedan causarse a los pacientes atendidos en el centro, al personal del mismo o a terceras personas. Aportará una copia de éste, así como del último recibo abonado.



12. REQUISITOS MINIMOS PARA LA EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS MEDIANTE ULTRASONIDOS

12.1. BLOQUE A. EQUIPAMIENTO

12.1.1. Normativa

Será de obligado cumplimiento, en todo momento, la normativa legal local, autonómica y estatal vigente, para la construcción, ubicación, puesta en marcha y funcionamiento de este tipo de instalaciones, entre otros, el Real Decreto 1277/2003 de 10 de octubre, que regula las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, el Decreto 49/2005 de 23 de junio, de la Comunidad de Castilla y León, por el que se establece el régimen jurídico y el procedimiento para la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (derogado parcialmente por del Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo)de todos los equipos disponibles, electromédicos o no, y para el material fungible que se precise, debiendo estar todos ellos validados y en correcto estado de funcionamiento.

12.1.2. Equipamiento Ecografía General

- **Equipo:** Tendrá las siguientes características:
 - Sistema digital de alta resolución.
 - Sistema de procesamiento doble haz de 256 niveles de grises.
 - Rango dinámico 80 db.
 - Posibilidad de doble imagen en pantalla.
 - Cálculos de distancias (mínimo 4), áreas y volúmenes.
 - Admitirá transductores de más de 90 elementos.
- **Sondas:** Se dispondrá de:
 - 1 sonda abdominal convex con frecuencia de 3,5 Mhz.
 - 1 sonda de alta frecuencia para tiroides, testículo, mama y músculo esquelético de 7,5 Mhz.
- **Sistema de Registro.** Sistema de impresión de imágenes en papel o película radiográfica y formato digital DICOM para las imágenes que se pudieran descargar y fuese necesario en el PACS del hospital.

12.1.3. Equipamiento RM

- **Imán:**
 - Intensidad de campo magnético al menos igual a 1,5 Teslas.
 - Apantallamiento activo de homogeneidad mejor que 0'025 ppm (V RMS).



- Apertura mínima de imán de 60 cm, para poder realizar exploraciones de columna y músculo-esquelético.
- **Subsistema de radiofrecuencia:** Deberá incluir antenas de radiofrecuencia (ARF) para los estudios de columna, extremidades, superficie y otras localizaciones.
- **Sistema de gradiente:**
 - Debe permitir espesores de corte fino, con un mínimo igual o menor de 2,5 mm en 2DFT e igual o menor de 1 mm en 3DFT.
 - La intensidad será igual o superior a 15 mT/m.
 - La aceleración será igual o superior a 20 T/m/s.
 - El tiempo mínimo para alcanzar el gradiente máximo será igual o inferior a 1'6 /0,5 ms (TR/TE).

12.1.4. Equipamiento TC

- Certificado de instalación y puesta en marcha del fabricante del equipo TAC. En equipos de más de 10 años, Certificado del Fabricante de que se ha realizado una actualización mayor de software y hardware.
- TAC multidetector de al menos 16 filas de detectores
- Generador de Rayos X. Potencia de al menos 45 kw.
- Unidad de exploración (Gantry): Diámetro de al menos 60 cm
- Equipamiento de TAC complementario

12.1.5. Otro equipamiento. Se deberá disponer de:

- Farmacopea (oxígeno, bicarbonato, adrenalina, atropina, lidocaína, dopamina, dobutamina y aleudrina, etc) y equipamiento completo de reanimación cardiopulmonar (carro de RCP) incluyendo desfibrilador miocárdico (laringoscopio, tubos orotraqueales, vías venosas centrales y pulmonares, bolsa de resucitación unidireccional, etc).
- Oxigenoterapia, sistemas de vacío y aire comprimido, con mascarilla y gafas nasales adecuadas al paciente.
- Refrigerador convencional con registro gráfico de temperatura, para almacenamiento de material (fármacos, etc).
- Medicación y equipamiento completo para Anestesiología y Reanimación, en el caso de que se realicen exploraciones bajo anestesia.
- Otro equipamiento necesario se especificará, en su caso, en cada procedimiento concreto.

12.1.6. Seguridad y Mantenimiento. La entidad ofertante dispondrá de servicio técnico permanente y de mantenimiento (preventivo y reparador), estableciendo, en este sentido, las condiciones de colaboración con las empresas suministradoras para reducir al mínimo los tiempos de parada del equipo (tiempo máximo de parada dos días laborables), e igualmente, la entidad ofertante se responsabilizará de la garantía de calidad de funcionamiento, de acuerdo con las instrucciones de cada suministrador y del restablecimiento de las condiciones que,



aun no suponiendo un paro en la actividad, puedan comprometer la calidad de las exploraciones y/o la seguridad de los pacientes. Se deberá presentar copia compulsada del contrato con el servicio técnico correspondiente, así como la copia del último informe de revisión efectuado.

12.2. BLOQUE B. LOCALES E INSTALACIONES

Será de obligado cumplimiento la normativa legal local, autonómica y estatal vigentes, para la construcción y puesta en marcha de este tipo de instalaciones, así como toda la normativa de aplicación general y en particular, toda el área estará dotada de la adecuada y preceptiva protección para la radiofrecuencia y para el campo magnético, tanto personal como estructural, con sus señalizaciones correspondientes. La resonancia magnética y el procedimiento de Tomografía Axial Computarizada (TAC) estarán ubicados en una instalación fija.

12.2.1. Ausencia de barreras arquitectónicas No existirán barreras arquitectónicas en acceso a:

- **Edificio:** Permitirá acceso a la zona de entrada del edificio, de vehículos de transporte sanitario.
- **Instalaciones:** Permitirá el acceso y desplazamiento de pacientes en silla de ruedas y camilla.

12.2.2. Locales y dependencias

- **Zona de Recepción/Admisión de pacientes y acompañantes**
 - Permitirá la realización de las funciones de atención e información al usuario, planificación de las pruebas, control de asistencia de los pacientes, procesos administrativos del servicio y atención telefónica. Posibilidad de informar a personas tanto con movilidad normal como reducida (silla de ruedas o camilla).
 - Ha de estar emplazada a la entrada del centro, en lugar visible y estratégico para que pueda ser vista por cualquier persona que entre.
- **Secretaría y área administrativa.** Existirá el equipamiento necesario para:
 - Valoración de imágenes
 - Realización y envío de informes de resultados.
 - Archivo de informes en soporte informático.
 - Archivo de informes e historia clínica en soporte convencional.
- **Sala de Espera.** Superficie de 10 m² para pacientes y acompañantes, con capacidad para 8 personas sentadas, permitiendo la entrada y estacionamiento de dos sillas de ruedas y de una camilla.



- **Sala de Exploración Ecográfica.** Existirá un local de consulta con zona de exploración diferenciada que garantice la intimidad del paciente, equipado con lavamanos y con una superficie de 12 m²
- **Vestuarios y Aseos**
 - Aseos públicos, con lavabo e inodoro, diferenciado para mujeres y otro para hombres.
 - Aseo público para discapacitados físicos. Deberá disponer de lavabo e inodoro y de todo el equipamiento básico para discapacitados físicos que establezca la normativa legal vigente, en cada momento.
 - Vestuario usuarios. Área diferenciada. Esta área podrá ser independiente o estar integrado/anexo al local de consulta o al área de exploraciones funcionales.
 - Vestuario y aseo de personal: Existirá un vestuario y un aseo para uso del personal.
- **Archivo.** Espacio destinado para archivo de historias clínicas. Deberá garantizar la privacidad y seguridad de los documentos.
- **Almacén.** Zona de almacén de material y medicamentos.

12.2.3. Aspectos Generales. Instalación de un sistema de aire acondicionado y calefacción.

12.2.4. Servicio de Limpieza y mantenimiento. La entidad contratada deberá disponer de los medios necesarios, propios o contratados, para garantizar la limpieza y mantenimiento de todas las instalaciones.

12.3. BLOQUE C. RECURSOS HUMANOS

La entidad adjudicataria del servicio deberá contar con el número de profesionales necesario para una óptima prestación, que deberá estar en posesión de la titulación establecida por la legislación vigente y cumplir con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

12.3.1. Personal Facultativo.

- Los estudios de ecografías, y las lecturas de imágenes diagnósticas de TC y RM deberán ser realizados por facultativos especialistas en radiodiagnóstico, con una experiencia mínima acreditada de 4 años y 3000 procedimientos en estudios ecográficos.
- En caso de realizar exploración bajo anestesia, debe contar con un facultativo especialista en Anestesiología y Reanimación con una experiencia mínima acreditada de 4 años.



12.3.2. Personal Sanitario No Facultativo.

- Un enfermero/a, con la titulación establecida en la legislación vigente y con una experiencia mínima de 6 meses en desarrollo de la actividad correspondiente a la especialidad de que se trate.
- Un Técnico Especialista en Radiodiagnóstico, con experiencia acreditada en IRM, mínima de 6 meses

12.3.3. Personal No Sanitario. Un Administrativo con la titulación establecida en la legislación vigente.

12.4. BLOQUE D. ORGANIZACIÓN EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

12.4.1. Horario de Servicio

- **Realización del procedimiento con carácter ordinario de los procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos:** Se citarán 12 ecografías por día, de lunes a viernes, en horario de 9-12:30 (6 ecografías) y 16:30-19:30 (6 ecografías). La estructura y capacidad de estas agendas, las podrá definir y modificar el centro contratado, previa notificación y autorización del centro contratante, para que se ajusten a las necesidades de la demanda. El centro contratante, definirá los mecanismos para seleccionar los pacientes a citar en esas agendas, y se encargará de notificarles telefónicamente a los pacientes de la fecha, hora y ubicación de la citación.
- Durante el horario establecido en el apartado anterior se realizarán los procedimientos objeto del servicio a pacientes enviados desde régimen ambulatorio.
- **Realización del procedimiento con carácter ordinario para emisión de informes de imagen diagnóstica (TC/RM):** El volumen de estudios a informar, podrá variar diariamente en función de la demanda y volumen de las listas de espera del centro contratante. En todos los casos, será el centro contratante quien defina el número de estudios a leer, y diariamente (de lunes a viernes hábiles) seleccionará dichos estudios y habilitará el acceso a las imágenes a través del sistema de integración descrito.

12.4.2. Recepción de la solicitud de realización del procedimiento.

- Para los procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos, diariamente el centro contratante, enviará al centro contratado, la relación de pacientes citados con fecha y hora, en las agendas descritas. Adicionalmente, adjuntará escaneado los volantes de petición de cada uno de los estudios y un enlace para que el centro contratado pueda cargar mediante el sistema de integración, las imágenes y los informes una vez realizado el estudio. El envío diario del listado de pacientes al centro contratado, así como la copia escaneada de los volantes de petición y el enlace para la carga de resultados, se hará mediante un correo electrónico, como archivo adjunto cifrado.



- Para la emisión de informes de imagen diagnóstica, diariamente el centro contratante, enviará al centro contratado, el listado de estudios solicitados. Adicionalmente, adjuntará escaneado los volantes de petición de esos estudios, así como cualquier informe previo de TC o RM que tenga cada paciente y que contribuya en el análisis comparativo y evolutivo del estudio actual. Se adjuntará también el enlace de acceso a esas imágenes, que será el mismo que se usará por el centro contratado para la carga de resultados. El envío de esta información se hará mediante correo electrónico, como archivo adjunto cifrado.
- En el caso de los informes de imagen diagnóstica, a cada paciente, se le definirá en el envío diario, la fecha de la cita sucesiva que tiene agendada para valorar esos resultados. El centro contratado, priorizará la lectura de los estudios, en función de la fecha de esa cita sucesiva.

12.4.3. Comunicación de la fecha de realización del procedimiento (Citación)

- Para los procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos, la fecha de realización del procedimiento, será informada telefónicamente al paciente, por el centro contratante, basándose en las agendas previamente acordadas con el centro concertado. En todos los casos, desde la recepción de la solicitud de la ecografía por parte del servicio de admisión del centro contratado hasta la fecha asignada, se aceptará como máximo un plazo de 5 días laborables. Para el contacto con el paciente, se realizarán tres intentos para contactar vía telefónica en diferentes franjas horarias, con el paciente o con personas próximas a él.
- El Complejo Asistencial de Segovia facilitará al centro contratado los siguientes datos del paciente:
 - Datos del paciente: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y Nº de identificación del paciente, y teléfono de contacto.
 - Datos del peticionario.
 - Motivo de la solicitud del estudio.
 - Tipo de estudio solicitado.
 - Enlace cifrado con usuario y contraseña, para visualizar las imágenes del estudio actual y los estudios previos relacionados y para cargar las imágenes e informe del estudio solicitado.

12.4.4. Demoras en la realización del Procedimiento: Las demoras máximas permitidas en el inicio del procedimiento (contando a partir del momento de solicitud desde el Servicio de Admisión del Complejo Asistencial de Segovia), salvo en el caso de que se especifique una fecha concreta posterior en el impreso de solicitud, serán de 5 días laborales para los procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos, y de 24 horas para la emisión de informes de imagen diagnóstica

12.4.5. Formato y Transmisión de los Informes

- Los informes generados por la entidad adjudicataria se adecuarán a un modelo consensuado con el centro contratante y que facilite su utilización posterior a efectos de codificación, seguimiento, etc.



- El centro contratante opta por un formato electrónico de las imágenes, para su transmisión electrónica, los informes compartirán la misma vía de envío. Para ello, se utilizará el sistema de integración digital previamente descrito.
- Igual que las imágenes, los informes preservarán los datos demográficos del paciente, el número de historia y otros identificadores.
- Siempre que sea solicitado por el centro contratante, los informes serán generados en estándar de mensajería HL7 siguiendo las guías de integración de SACYL, para su posterior integración en la Historia Clínica Electrónica y el Sistema de Información Radiológica (RIS) corporativo de SACYL existente en cada momento
- Asimismo, el adjudicatario dispondrá de un sistema de archivo de documentación clínica que garantice la seguridad de la información desde el punto de vista de integridad, confidencialidad y disponibilidad y el cumplimiento de la legislación vigente en cada momento durante el plazo de ejecución del contrato relativa a la protección de datos de carácter personal.
- Los informes deberán ser emitidos por los radiólogos de la entidad adjudicataria y su posterior entrega al centro contratante.

12.4.6. Protocolo de Exploración para emisión de informes de imagen diagnóstica (RM).

- Las exploraciones deberán realizarse con equipos de intensidad al menos igual a 1,5 Teslas y apertura mínima de imán de 60 cm.
- Las características que se describen a continuación tienen la consideración de requisitos mínimos para la realización de la exploración ofertada.
- En cada una de las exploraciones se deberá realizar estudio, al menos, con dos secuencias distintas y dos proyecciones espaciales distintas (por ejemplo, una secuencia en cada proyección).
- Teniendo en cuenta la evolución del conocimiento científico, los protocolos de exploración, pueden ser modificados, siempre con los objetivos de conseguir mayor facilidad de realización con menores molestias para el paciente, así como un aumento en su capacidad diagnóstica. Estas modificaciones deberán contar con la aprobación del Órgano de Contratación.
- El centro concertado dispondrá del protocolo de exploración por escrito en el que consten las indicaciones de las diversas proyecciones.
- Siempre que las características técnicas del equipamiento lo permitan, y basándonos en el conocimiento científico, en cada protocolo específico, de forma general o en un paciente concreto, la entidad contratada modificará, a requerimiento del Órgano de Contratación, las características del mismo (grosor de corte, separación entre cortes, proyecciones, secuencias, etc.).
- Todas las pruebas estarán denominadas y codificadas por el catálogo de pruebas radiológicas SERAM.

12.4.7. Procedimientos normalizados de trabajo. Existirán procedimientos normalizados escritos y específicos de las siguientes actividades:

- Asistencia sanitaria prestada en cada uno de los procesos, exploraciones y técnicas diagnósticas y/o terapéuticas utilizadas tanto por facultativos como por personal sanitario no facultativo.



- Tareas Administrativas y de atención al paciente por personal no sanitario.
- Limpieza y mantenimiento de equipos e instalaciones.

12.5. BLOQUE E. INFORME DE RESULTADOS

12.5.1. Contenido del informe

- **Datos de Identificación:**
 - Datos del paciente: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y Nº de identificación del paciente.
 - Datos del peticionario.
 - Tipo de estudio realizado.
- **Datos de realización del procedimiento**
 - Información Clínica aportada en el impreso de solicitud.
 - Protocolo de realización de la prueba: Protocolo clínico y protocolo de ejecución.
 - Incidencias durante la realización de la prueba (si las hubiere).
 - Descripción y límites de la/s zona/s anatómica/s explorada/s.
 - Descripción morfológica de los hallazgos significativos, relacionados o no con el diagnóstico que figure en el impreso de solicitud. Diagnóstico diferencial y actuaciones recomendadas si fuera necesario.
 - Descripción de los hallazgos del estudio histológico y el procedimiento de obtención de la muestra para el mismo en el caso de su realización.
 - Juicio Clínico (diagnóstico) basándose en los hallazgos de exploración y en los datos clínicos aportados en el impreso de solicitud.
 - Datos de identificación del especialista que realiza el informe, Nº de colegiado, especialidad, fecha de exploración y firma y sello del mismo.

12.5.2. Demora en la emisión y entrega del informe. Las demoras máximas permitidas en el inicio del procedimiento (contando a partir del momento de solicitud desde el Servicio de Admisión del Complejo Asistencial de Segovia), salvo en el caso de que se especifique una fecha concreta posterior en el impreso de solicitud, serán de 5 días laborales para los procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos, y de 24 horas para la emisión de informes de imagen diagnóstica

12.5.3. Soporte del Informe. Escrito acompañado de documentación gráfica, en su caso, de la/s exploración/es complementarias realizada/s. En la documentación gráfica deberán figurar los datos de identificación del paciente.

12.5.4. Procedimiento de Entrega. Los informes de resultado y las imágenes se integrarán telemáticamente en el Complejo Asistencial de Segovia. La forma de integración será según se indica en **Anexo I**.

- El adjudicatario dispondrá antes de la firma del contrato la integración validada con el Complejo Asistencial de Segovia



- Como medida de contingencia, en caso de impedimento técnico sobrevenido y solo bajo autorización del centro contratante, se podrá enviar el informe por otros métodos electrónicos alternativos, o en papel.
- Las pruebas realizadas deberán ser integrados en el sistema de información del Complejo Asistencial de Segovia en el plazo máximo de 5 días laborales para los procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos a contar desde la fecha de realización de la prueba y de 1 día para la emisión de informes de imagen diagnóstica, a contar desde el envío de la solicitud desde el centro contratante.
- Si al realizar la prueba o hacer la lectura de una imagen se detectasen hallazgos urgentes, estos deberán ser comunicados al servicio de admisión del Complejo Asistencial de Segovia en el plazo máximo de 24 horas laborables, mediante correo electrónico: medadmission.hgse@saludcastillayleon.es

En Segovia,

LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA

Código Seguro de Verificación CSV: P24016T0UVVW05LY5F6IF5HQ9XKIU255IIHQ
Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P24016T0UVVW05LY5F6IF5HQ9XKIU255IIHQ>



ANEXO 1

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FLUJO DE INFORMACIÓN

1. Introducción

Este anexo especifica el flujo de integración de partida, pudiendo sufrir ligeras variaciones en el proceso de validación bajo acuerdo de ambas partes. Se realizará a través de dos grupos de protocolos:

- HL7 (Health Level Seven www.hl7.org), y en concreto, con la especificación usada en los hospitales de SACYL definida en las "Guías de integración de Sacyl". <https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/estandaresint>.
- DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine).

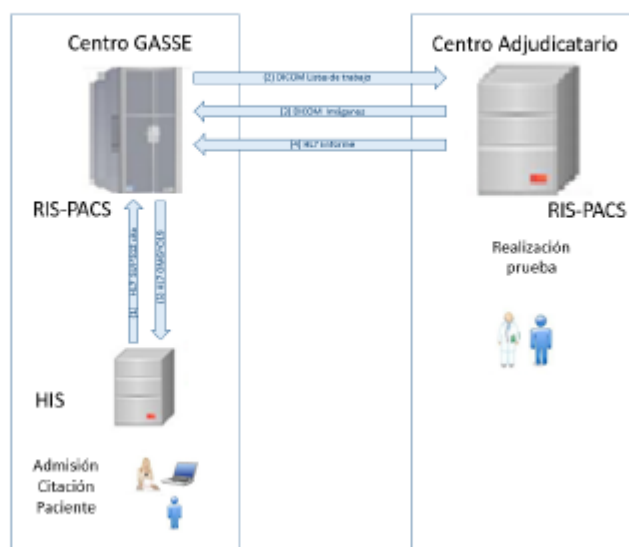
2. Descripción del proceso

Las funciones del Centro GASSE y del Centro Adjudicatario se distribuyen de la siguiente forma:

- El Centro GASSE organizará las agendas necesarias en coordinación con el Adjudicatario definiendo hora de comienzo, hora de finalización, duración de las pruebas, número de pacientes por día, etc.
- El Centro GASSE citará a los pacientes en las agendas definidas en el punto anterior preparadas para este fin. En este punto se solicita al paciente el permiso para su derivación al centro del Adjudicatario.
- El Centro GASSE, enviará las citas al Centro Adjudicatario con la información del identificador asignado por el RIS del Centro GASSE para dicha prueba. Este identificador se incluirá en la devolución posterior de los resultados de la prueba vía DICOM.
- El Centro Adjudicatario enviará las imágenes e informes de las pruebas realizadas a Centro GASSE. Además, informará de cualquier incidencia que se produzca incluyendo las pruebas no realizadas, indicando el motivo.



El esquema de intercambio de mensajes entre el Centro GASSE y el Centro del Adjudicatario es el siguiente:



1. Las citas que se dan en el servicio de Admisión en las agendas correspondientes se envían desde el HIS al RIS de Centro GASSE
2. El RIS de Centro GASSE envía al RIS del Adjudicatario la lista de trabajo con los pacientes citados.

El paciente acude al Centro Adjudicatario, y se le realizan la prueba programada.

1. El PACS del Centro Adjudicatario envía al PACS Centro de la GASSE las evidencias realizadas (imágenes) usando los identificadores recuperados en la lista de trabajo, con lo que estudio pasa a estar realizado en el RIS del centro GASSE.
2. El RIS del Centro Adjudicatario envía el informe usando los identificadores recuperados en la lista de trabajo, que estudio pasa a estar informado en el RIS del centro GASSE.
3. El RIS del centro GASSE envía mensaje OMG^O19 de notificación de realización de prueba al HIS.

En el RIS del Centro GASSE se comprueba la actividad no realizada y se envían los mensajes correspondientes al HIS.



ANEXO 2

2017 PREPARACIÓN DEL COLON CON CASENGLICOL

Para que el examen salga bien y **PARA EVITAR REPETICIONES, SE ACONSEJA SEGUIR RIGUROSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES**

En los 4 días previos a la prueba no debe tomar medicación que contenga **hierro**.

Si toma **Adiro 100mg**, **NO** debe suspenderlo para la realización de la prueba.

Si toma cualquier otro **antiagregante, anticoagulante**, deberá consultarlo con su médico.

3 días antes de la prueba se seguirá una dieta **pobre en residuos**:

PUEDE TOMAR

Pasta
Caldos (no de verduras)
Carnes y pescados a la plancha o hervidos
Galletas sin fibra
Pan tostado y mantequilla en poca cantidad
Zumos filtrados
Café, té e infusiones y líquidos sin gas

NO PUEDE TOMAR

Ensaladas, verduras, legumbres y frutas
Patatas, féculas
Carnes y pescados en salsa o estofados
Embutidos
Leche y productos lácteos
Grasas y pasteles
Chocolates y bebidas con gas

24 horas antes de la exploración y el mismo día de la exploración la alimentación será líquida: Agua, caldos o zumos colados, infusiones, bebidas sin burbujas y bebidas isotónicas (Aquarius por ejemplo).

INSTRUCCIONES DE TOMA DE CASENGLICOL

Si su cita es por la mañana (8:00h-15:00h.):

El día anterior a la exploración: A las 20:00h. tomará **10 sobres de CASENGLICOL**, cada sobre diluido en un vaso (250 ml) de agua. Beber la solución despacio a razón de un vaso cada 10-15 minutos.

4 horas antes de la prueba: Tomará **6 sobres de CASENGLICOL** de la misma manera que se indica arriba hasta finalizar (cada 10 minutos). **Acabar la preparación al menos 3 horas antes de la cita de la colonoscopia y no tomar nada más hasta la prueba (ni sólidos ni líquidos, incluida agua).**

Si su cita es por la tarde (A partir de las 15:00h.):

Utilizar la misma pauta que se ha indicado anteriormente y que figura en las instrucciones del preparado, tomando los **16 sobres entre las 7 y las 11 de la mañana del mismo día de la prueba. No tomar nada más desde 3 horas antes de la prueba (ni sólidos, ni líquidos, incluida agua).**

OBSERVACIONES

No traiga ropa ajustada (le molestará durante y después de la exploración) ni joyas. No se pinte los labios ni las uñas.

Después de la prueba permanecerá entre 1-2 horas en nuestro Servicio bajo vigilancia, hasta que esté recuperado para ir a su domicilio. **Después de la prueba no podrá conducir** (debido a la sedación). **Venga acompañado.**

Si no puede acudir a la cita avise lo antes posible llamando a Citaciones: **(921) 419274**



ANEXO 3

2017 PREPARACIÓN DEL COLON CON CITRAFLEET

Para que el examen salga bien y **PARA EVITAR REPETICIONES, SE ACONSEJA SEGUIR RIGUROSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES**

En los 4 días previos a la prueba no debe tomar medicación que contenga hierro.

Si toma Adiro 100mg, NO debe suspenderlo para la realización de la prueba.

Si toma cualquier otro antiagregante, anticoagulante, deberá consultarlo con su médico.

3 días antes de la prueba se seguirá una dieta pobre en residuos:

PUEDE TOMAR

Pasta
Caldos (no de verduras)
Carnes y pescados a la plancha o hervidos
Galletas sin fibra
Pan tostado y mantequilla en poca cantidad
Zumos filtrados
Café, té e infusiones y líquidos sin gas

NO PUEDE TOMAR

Ensaladas, verduras, legumbres y frutas
Patatas, féculas
Carnes y pescados en salsa o estofados
Embutidos
Leche y productos lácteos
Grasas y pasteles
Chocolates y bebidas con gas

24 horas antes de la exploración y el mismo día de la exploración la alimentación será líquida: Agua, caldos o zumos colados, infusiones, bebidas sin burbujas y bebidas isotónicas (Aquarius por ejemplo).

INSTRUCCIONES DE TOMA DE CITRAFLEET

Si su cita es por la mañana (8:00h-15:00h)

El día anterior a la exploración: A las 21:00h. tomará un sobre de CITRAFLEET disuelto en 1 vaso grande de agua, y después de unos 15 minutos, tomará como mínimo 2 litros de agua, bebida isotónica (Aquarius por ejemplo), caldos, infusiones, zumos colados envasados (ni de kiwi ni de tomate),...beber lentamente durante las siguientes 3 horas.

4 horas antes de la prueba: Tomará el otro sobre de CITRAFLEET disuelto de la misma manera que el anterior, y después de unos 15 minutos, tomará aproximadamente 1 litro de agua, bebida isotónica (Aquarius por ejemplo), caldos, infusiones, zumos colados envasados (ni de kiwi ni de tomate),...beber lentamente durante los siguientes 45 minutos.

Acabar la preparación al menos 3 horas antes de la cita de la colonoscopia y no tomar nada más hasta la prueba (ni sólidos ni líquidos, incluida agua).

Si su cita es por la tarde (A partir de las 15:00h.)

El mismo día de la prueba tomará el primer sobre de CITRAFLEET a las 7:00h disuelto en 1 vaso grande de agua, y después de unos 15 minutos, tomará como mínimo 2 litros de agua, bebida isotónica (Aquarius por ejemplo), caldos, infusiones, zumos colados envasados (ni de kiwi ni de tomate),...beber lentamente durante las siguientes 3 horas.

4 horas antes de la prueba: Tomará el otro sobre de CITRAFLEET disuelto de la misma manera que el anterior, y después de unos 15 minutos, tomará aproximadamente 1 litro de agua, bebida isotónica (Aquarius por ejemplo), caldos, infusiones, zumos colados envasados (ni de kiwi ni de tomate),...beber lentamente durante los siguientes 45 minutos.

Acabar la preparación al menos 3 horas antes de la cita de la colonoscopia y no tomar nada más hasta la prueba (ni sólidos ni líquidos, incluida agua).

OBSERVACIONES

No traiga ropa ajustada (le molestará durante y después de la exploración) ni joyas. No se pinte los labios ni las uñas.

Después de la prueba permanecerá entre 1-2 horas en nuestro Servicio bajo vigilancia, hasta que esté recuperado para ir a su domicilio. Después de la prueba no podrá conducir (debido a la sedación). Venga acompañado.

Si no puede acudir a la cita avise lo antes posible llamando a Citaciones: (921) 419274

